AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

SERIE AEE · PERFIL V3

REPASO FINAL

PEDIATRÍA GENERAL

Neonatología

28 temas · 1 página cada uno · **7** días de plan de repaso

Índice

Cómo usarlo. Un tema por página: lee «Lo que te preguntan», recorre el algoritmo y termina en las trampas y la regla de oro. Después haz las preguntas del Libro Gordo que indica el pie.

★★★ alta · ★★☆ media · ★☆☆ baja — según cuántas preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) hay en los códigos del tema.
Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento.

01 Crecimiento, Desarrollo & Vacunas PNI

★★★ 18.1. Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T) 4
★★★ 18.2. Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI) 5
★★★ 18.3. Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026 6
★★★ 18.4. Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación (Vitamina D / Fierro) 7
★☆☆ 18.26. Genética y Dismorfias: Síndrome de Down (Trisomía 21) y Síndromes Genéticos Frecuentes 8
★☆☆ 18.28. Pediatría Psicosocial: Maltrato Infantil, Entrevista Clínica, Conductas de Riesgo en el Adolescente y Psiquiatría de Enlace 9

02 Respiratorio Pediátrico & Urgencias

★★☆ 18.5. Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado GES 10
★☆☆ 18.6. Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona GES 11
★★☆ 18.7. Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización GES 12
★★☆ 18.8. Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía 13
★★☆ 18.23. Cardiología Pediátrica: Soplos, Insuficiencia Cardíaca, Arritmias, Endocarditis y Electrocardiograma 14
★★☆ 18.24. Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica, Intoxicaciones y Prevención de Accidentes 15

03 Infecciones, Exantemas & Digestivo Pediátrico

★☆☆ 18.9. Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo 16
★★★ 18.10. Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki) 17
★★★ 18.11. Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico 18
★★☆ 18.12. Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP) vs Invaginación Intestinal 19
★★★ 18.13. Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis 20
★★☆ 18.14. Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico 21
★☆☆ 18.25. Inmunodeficiencias Primarias, Infecciones Recurrentes, Hepatomegalia e Interpretación del Hemograma Pediátrico 22
★☆☆ 18.27. Uroginecología Pediátrica: Fimosis, Sinequias Vulvares y Enuresis 23

04 Neonatología & Sala de Partos

★★★ 18.15. Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR 24
★★☆ 18.16. Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal GES 25
★★★ 18.17. Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia 26
★☆☆ 18.18. Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM GES 27
★☆☆ 18.19. Sepsis Neonatal: Precoz (< 72 h) vs Tardía (> 72 h), Esquema Ampicilina + Aminoglucósido y Cefotaxima 28
★☆☆ 18.20. Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato 29
★★★ 18.21. Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo GES 30
★★☆ 18.22. Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC GES N° 23): Maniobras de Ortolani y Barlow, Radiografía a los 3 Meses y Correas de Pavlik GES 31

Índice · continuación

Números que tienes que saber	32
Fármacos de primera línea	35
GES de la especialidad	36
Plan de repaso de 7 días	37
Índice por prioridad ★	39

BLOQUE 01 · CRECIMIENTO, DESARROLLO & VACUNAS PNI

18.1 Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

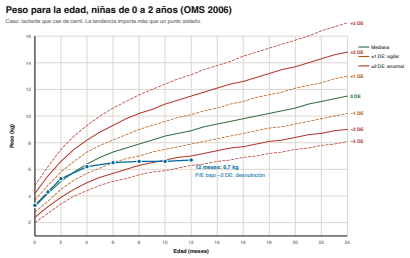
★★★ PRIORIDAD ALTA
21 preguntas reales 2013–2025

2.01.3.003 Diagnóstico nutricional — Conocimiento general

También: Antropometría en la edad pediátrica · Desnutrición · Obesidad · Alteraciones del desarrollo puberal · Talla baja · Macro y microcefalia · Promoción de salud y estilos de vida saludables · Supervisión de salud- escolar · Supervisión de salud- lactante · Radiografía de edad ósea · Prevención de la obesidad

LO QUE TE PREGUNTAN

- En menores de **5 años**, el diagnóstico nutricional oficial se establece mediante el indicador Peso para la Talla (P/T).
- A partir de los **5 años** (**60 meses**) hasta los **19 años**, se utiliza el Índice de Masa Corporal para la Edad (IMC/E).
- Riesgo de desnutrición corresponde a P/T entre -1.0 y -1.9 DE; Desnutrición a P/T ≤ -2.0 DE.
- Sobrepeso corresponde a P/T o IMC/E entre +1.0 y +1.9 DE; Obesidad entre +2.0 y +2.9 DE; Obesidad severa ≥ +3.0 DE.
- La Talla para la Edad (T/E) refleja nutrición y crecimiento crónico; T/E ≤ -2.0 DE define Talla Baja.
- La medición hasta los **24 meses** se realiza acostado (longitud con infantómetro) y desde los **2 años** de pie (estatura con estadiómetro).



PESO PARA LA EDAD
Dibujo propio (esquema)

ALGORITMO · EVALUACIÓN NUTRICIONAL: QUÉ INDICADOR USAR Y QUÉ HACER

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

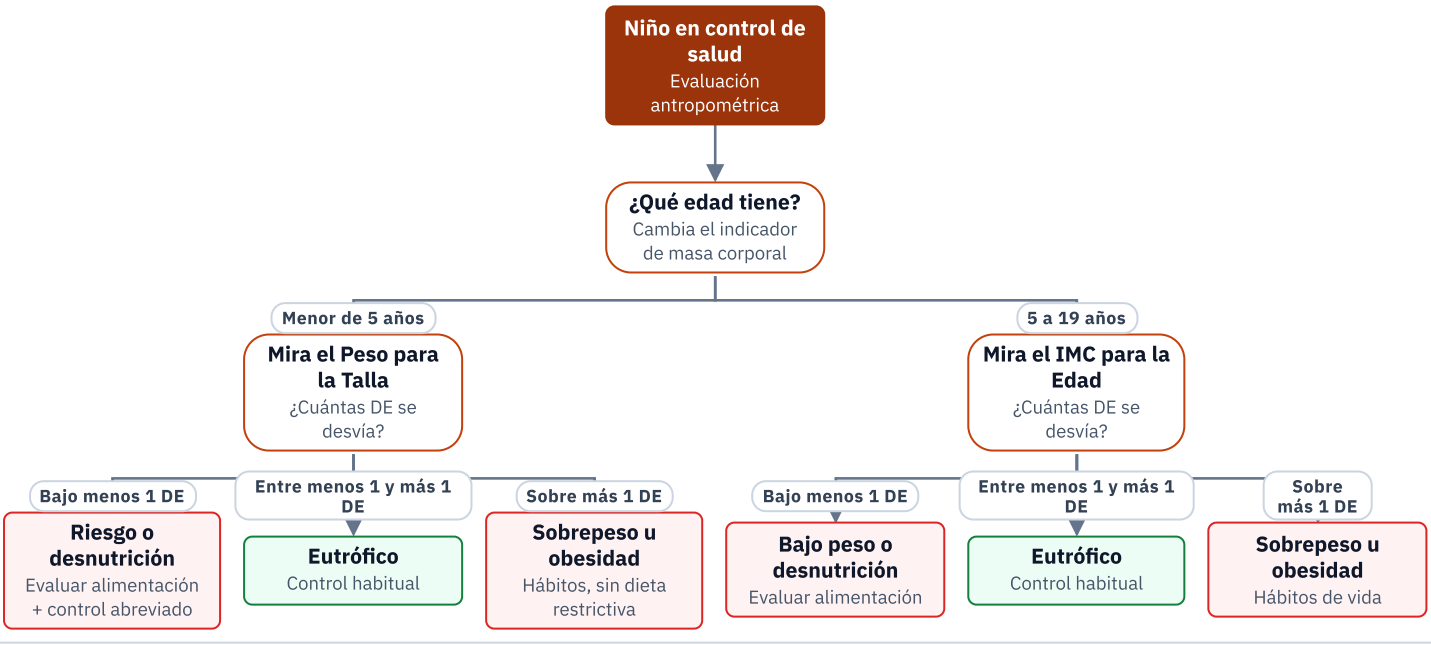


TABLA 18.1 · CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL SEGÚN PUNTAJE Z (DESVIACIONES ESTÁNDAR) MINSAL / OMS

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL	MENORES DE 5 AÑOS (P/T)	DE 5 A 19 AÑOS (IMC/E)	TALLA PARA LA EDAD (T/E)
Obesidad Severa	≥ +3.0 DE	≥ +3.0 DE	—
Obesidad	+2.0 a +2.9 DE	+2.0 a +2.9 DE	—
Sobrepeso	+1.0 a +1.9 DE	+1.0 a +1.9 DE	—
Eutrófico (Normal)	-0.9 a +0.9 DE	-0.9 a +0.9 DE	-1.9 a +1.9 DE
Riesgo Desnutrición / Bajo Peso	-1.0 a -1.9 DE	-1.0 a -1.9 DE	—
Desnutrición / Talla Baja	≤ -2.0 DE	≤ -2.0 DE	≤ -2.0 DE

REGLA DE ORO **Menor de 5 años: Peso/Talla** — Define desnutrición y obesidad

PRACTICA **Libro Gordo Pediatría General**, preguntas **8–9, 20, 73** (págs. 14–15, 23) · solucionario págs. 26–28, 35.

Clase 18.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · CRECIMIENTO, DESARROLLO & VACUNAS PNI

18.2 Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)

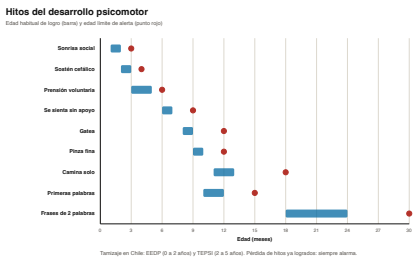
★★★ PRIORIDAD ALTA
19 preguntas reales 2013–2025

2.01.3.002 **Desarrollo psico-motor** — Conocimiento general

También: Retraso del desarrollo SM · Trastornos del desarrollo · Desarrollo cognitivo, afectivo y social a lo largo del ciclo vital · Síndrome hipertónico · Síndrome hipotónico · Trastornos del lenguaje · Supervisión de salud- pre-escolar · Trastornos de habla y lenguaje · Pesquisa de trastornos del lenguaje

LO QUE TE PREGUNTAN

- El EEDP se aplica en Chile de forma obligatoria a los **8 meses** y a los **18 meses** (rango **0 a 24 meses**).
- El TEPSI se aplica de forma universal a los **3 años** cumplidos (**36 meses**) en el control de salud infantil.
- **Puntajes**: Normal **≥ 85**; Riesgo = 70 a 84 (ingresa a Sala de Estimulación); Retraso < 70 (evaluación médica y derivación).
- **Hitos clave**: Sostén cefálico a los **3 meses**; sedestación sin apoyo a los **8 meses**; marcha independiente a los **12-15 meses**.
- Límite máximo para marcha independiente es **18 meses**; si no camina a los **18 meses** es bandera roja formal.



HITOS Y EDAD LÍMITE
Dibujo propio (esquema)

ALGORITMO · DESARROLLO PSICOMOTOR: HITO ESPERADO VERSUS BANDERA ROJA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

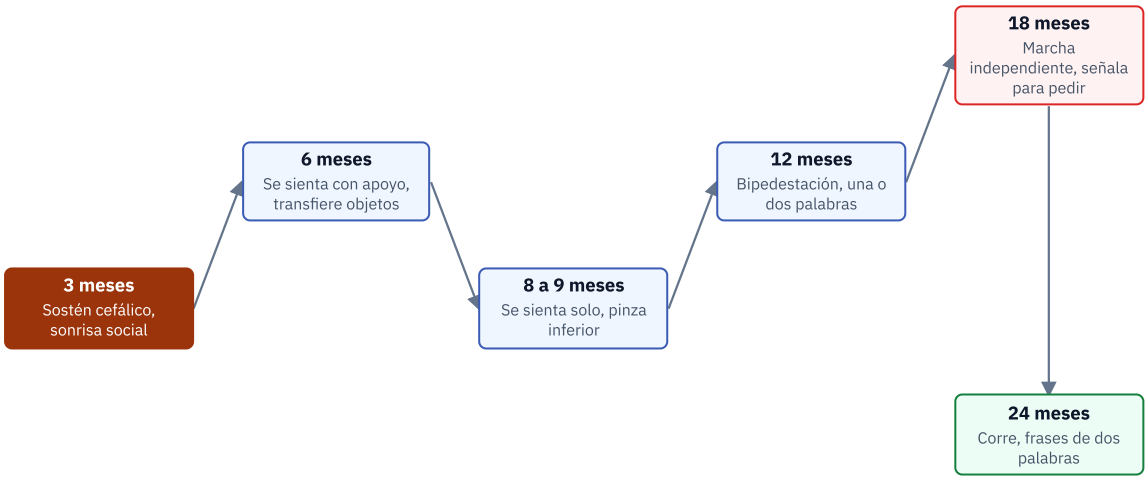


TABLA 18.2 · BATERÍAS DE TAMIZAJE DEL DESARROLLO PSICOMOTOR EN APS (CHILE CRECE CONTIGO)

PARÁMETRO	EEDP (LACTANTES)	TEPSI (PREESCOLARES)
Rango de Edad	0 a 24 meses	2 a 5 años (24 a 59 meses)
Edades Obligatorias MINSAL	8 meses y 18 meses	3 años cumplidos (36 meses)
Áreas Evaluadas	Motora, Coordinación, Lenguaje, Social	Coordinación, Lenguaje, Motricidad
Normal	Coeficiente de Desarrollo (CD) ≥ 85	Puntaje T ≥ 85
Riesgo	CD entre 70 y 84 puntos	Puntaje T entre 70 y 84 puntos
Retraso	CD < 70 puntos	Puntaje T < 70 puntos
Conducta en Riesgo	Sala de Estimulación + Reevaluar en 60 días	Sala de Estimulación + Reevaluar en 90 días
Conducta en Retraso	Evaluación médica + Derivación a Pediatría	Evaluación médica + Derivación a Especialidad

TRAMPAS EUNACOM

SITUACIÓN	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
EEDP o TEPSI entre 70 y 84 puntos	Sala de estimulación y reevaluar	Derivar de inmediato a especialista
No camina a los 18 meses	Examen neurológico y derivar	Esperar hasta los 24 meses
Prematuro con hitos “atrasados”	Calcular la edad corregida	Compararlo con su edad cronológica

REGLA DE ORO **EEDP: 8 y 18 meses** — TEPSI: 3 años

PRACTICA **Libro Gordo Pediatría General**, pregunta **10** (pág. 14) · solucionario pág. 27.

Clase 18.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · CRECIMIENTO, DESARROLLO & VACUNAS PNI

18.3 Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026

★★★ PRIORIDAD ALTA
20 preguntas reales 2013–2025

2.01.3.006 **Inmunizaciones en Chile (PNI y extra PNI)** — Conocimiento general

También: Inyecciones subcutáneas, intramusculares e intravenosas · Vacunas incluidas en el PNI (Plan Nacional de Inmunizaciones) · Vacunación de hepatitis A y B · Inmunizaciones en personas mayores

LO QUE TE PREGUNTAN

- A los 2, 4 y **6 meses** se administra la vacuna Hexavalente (DTPa-Hib-HB-VIP) intramuscular.
- **A los 12 meses se administran**: Tresvírica (SRP), Meningocócica conjugada ACWY y Neumocócica.
- **A los 18 meses se administran**: Hexavalente (refuerzo), Hepatitis A y Varicela.
- Las vacunas vivas atenuadas (BCG, SRP, Varicela) están contraindicadas en inmunosuprimidos y embarazadas.
- Infecciones leves afebriles o con fiebre baja (< **38.5°C**) NO contraindican la vacunación.

ALGORITMO · VACUNACIÓN: CALENDARIO Y CONTRAINDICACIONES

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

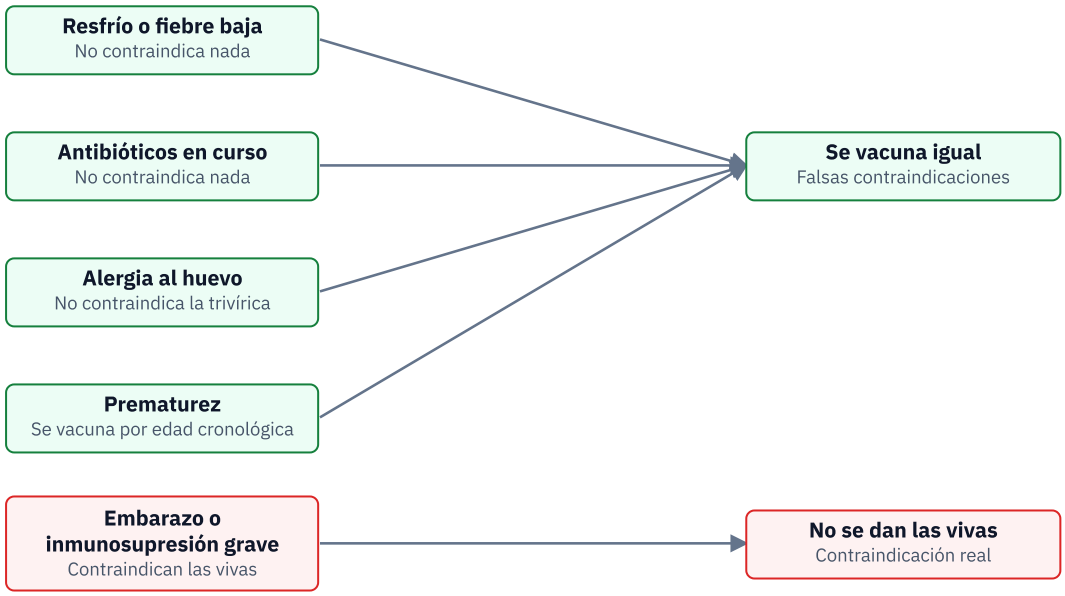


TABLA 18.3 · ESQUEMA RESUMEN DEL CALENDARIO PNI CHILE 2026

EDAD	VACUNAS ADMINISTRADAS	VÍA DE ADMINISTRACIÓN	TIPO DE VACUNA
Recién Nacido	BCG + Hepatitis B	Intradérmica / IM	Viva atenuada / Recombinante
2 meses	Hexavalente (1.ª) + Neumocócica (1.ª)	Intramuscular (muslos)	Inactivadas
4 meses	Hexavalente (2.ª) + Neumocócica (2.ª)	Intramuscular (muslos)	Inactivadas
6 meses	Hexavalente (3.ª)	Intramuscular	Inactivada
12 meses	Tresvírica (1.ª) + Meningococo ACWY + Neumococo (refuerzo)	Subcutánea / IM	Viva atenuada (SRP) / Conjugadas
18 meses	Hexavalente (4.ª) + Hepatitis A + Varicela (1.ª)	Intramuscular / Subcutánea	Inactivadas / Viva atenuada (Varicela)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

SITUACIÓN	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Alergia al huevo	Vacunar sin pruebas previas	Pedir test cutáneo o posponer
Fiebre baja o resfrío	Vacunar sin cambios	Posponer la vacuna
Corticoides en dosis alta	Suspender solo las vivas	Suspender todo el esquema

REGLA DE ORO **BCG y Hepatitis B: al nacer** — Hexavalente: 2, 4, 6 y 18 meses

PRACTICA **Libro Gordo Pediatría General**, pregunta **11** (pág. 14) · solucionario pág. 27.

Clase 18.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · CRECIMIENTO, DESARROLLO & VACUNAS PNI

18.4 Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación (Vitamina D / Fierro)

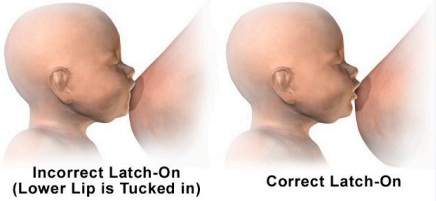
★★★ PRIORIDAD ALTA
12 preguntas reales 2013–2025

2.01.3.007 **Lactancia materna** — Conocimiento general

También: Alimentación normal · Lactancia · Higiene de la alimentación · Alteraciones pigmentarias · Prevención de anemias por carencias nutricionales

LO QUE TE PREGUNTAN

- La vitamina D se prescribe universalmente a todos los lactantes a **400 UI**/día desde el mes de vida hasta el año.
- En recién nacidos a término con LME, el hierro profiláctico se inicia a los **4 meses** a **1 mg/kg**/día.
- En prematuros (< **37 semanas**) o bajo peso (< **2.500 g**), el hierro profiláctico se inicia a los **2 meses** a **2-3 mg/kg**/día.
- La alimentación complementaria se inicia a los **6 meses** con la primera comida (almuerzo) + aceite vegetal crudo (**5 mL**).
- La cena se introduce entre los 8 y **9 meses** de vida.



INCORRECTO VS CORRECTO
Wikimedia Commons «Breastfeeding - Incorrect vs Correct Latch-On.png», CC BY-SA 4.0, BruceBlaus

ALGORITMO · SUPLEMENTACIÓN DEL LACTANTE: VITAMINA D Y HIERRO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

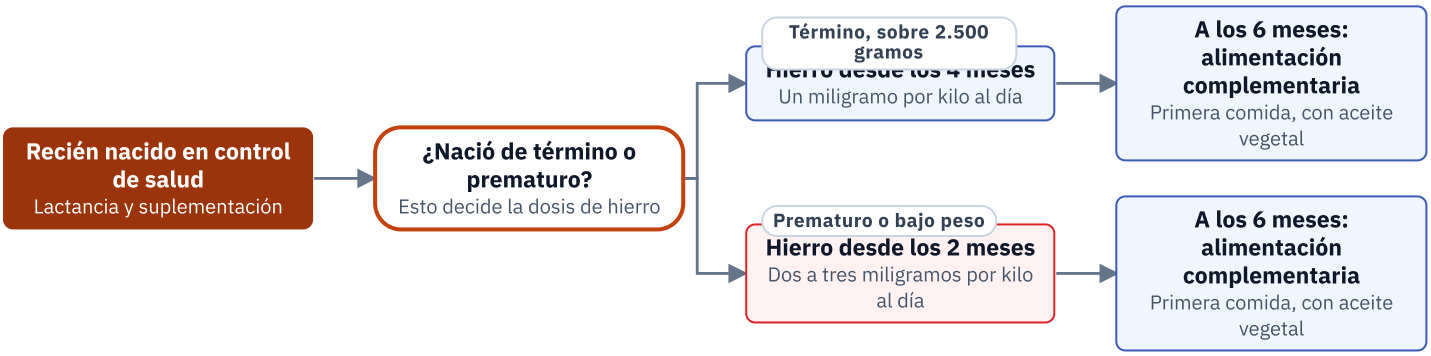


TABLA 18.4 · PROTOCOLO OFICIAL MINSAL DE SUPLEMENTACIÓN Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

EDAD / CONDICIÓN	ALIMENTACIÓN RECOMENDADA	SUPLEMENTACIÓN REQUERIDA	PAUTAS DE SEGURIDAD
0 a 6 meses	Lactancia materna exclusiva (LME)	Vitamina D 400 UI/día desde el mes 1	Libre demanda · No agua ni infusiones
Prematuro / < 2.500 g	LME o fórmula prematuro	Hierro 2-3 mg/kg/día desde los 2 meses + Vit D	Control estrecho de hemograma a los 6 meses
RN Término en LME	LME hasta los 6 meses	Hierro 1 mg/kg/día desde los 4 meses	Previene anemia ferropénica del lactante
6 meses cumplidos	1.ª comida (almuerzo) + fruta	Mantener Vitamina D + Hierro	Agregar 5 mL aceite vegetal crudo · Cero sal
8 a 9 meses	2.ª comida (cena) + almuerzo	Mantener suplementación hasta los 12 meses	Textura papilla semisólida / picados blandos
Menores de 1 año	Evitar alimentos prohibidos	—	¡Prohibida la miel (botulismo), sal, azúcar y leche de vaca!

TRAMPAS EUNACOM

SUPLEMENTO	RECIÉN NACIDO DE TÉRMINO	PREMATURO O BAJO PESO
Vitamina D	Cuatrocientas UI al día, desde el mes 1	La misma dosis, sin cambios
Hierro	Un miligramo por kilo, desde los 4 meses	Dos a tres miligramos por kilo, desde los 2 meses
Primera comida	6 meses, con aceite vegetal	Igual, salvo indicación distinta

REGLA DE ORO **Cuatrocientas UI al día** — Desde el mes 1 hasta el año

PRACTICA **Libro Gordo Pediatría General**, preguntas **76, 80** (págs. 23–24) · solucionario pág. 35.

Clase 18.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · CRECIMIENTO, DESARROLLO & VACUNAS PNI

18.26 Genética y Dismorfias: Síndrome de Down (Trisomía 21) y Síndromes Genéticos Frecuentes

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

2.01.1.134 Trisomía 21 — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Dismorfias

LO QUE TE PREGUNTAN

- La trisomía 21 libre explica el **95%** de los casos; la translocación robertsoniana (**3-4%**) obliga a estudiar el cariograma de los padres por el riesgo de recurrencia.
- El fenotipo clásico incluye hipotonía, fisuras palpebrales oblicuas, epicanto, pliegue palmar único, lengua protruyente y occipucio plano.
- Todo recién nacido con síndrome de Down requiere ecocardiograma (canal AV), tamizaje de hipotiroidismo, audición y visión; se vigila la atresia duodenal y la enfermedad de Hirschsprung.
- El cariograma confirma la trisomía 21; el microarray cromosómico es de primera línea en malformaciones múltiples o retraso del desarrollo sin causa evidente.
- **Marfán (FBN1)**: talla alta, aracnodactilia, hiperlaxitud y soplo de insuficiencia aórtica; el riesgo es la disección aórtica y requiere ecocardiograma y control oftalmológico.



FACIES TÍPICA
Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., Fig. 57.5E

ALGORITMO · RECIÉN NACIDO CON DISMORFIAS

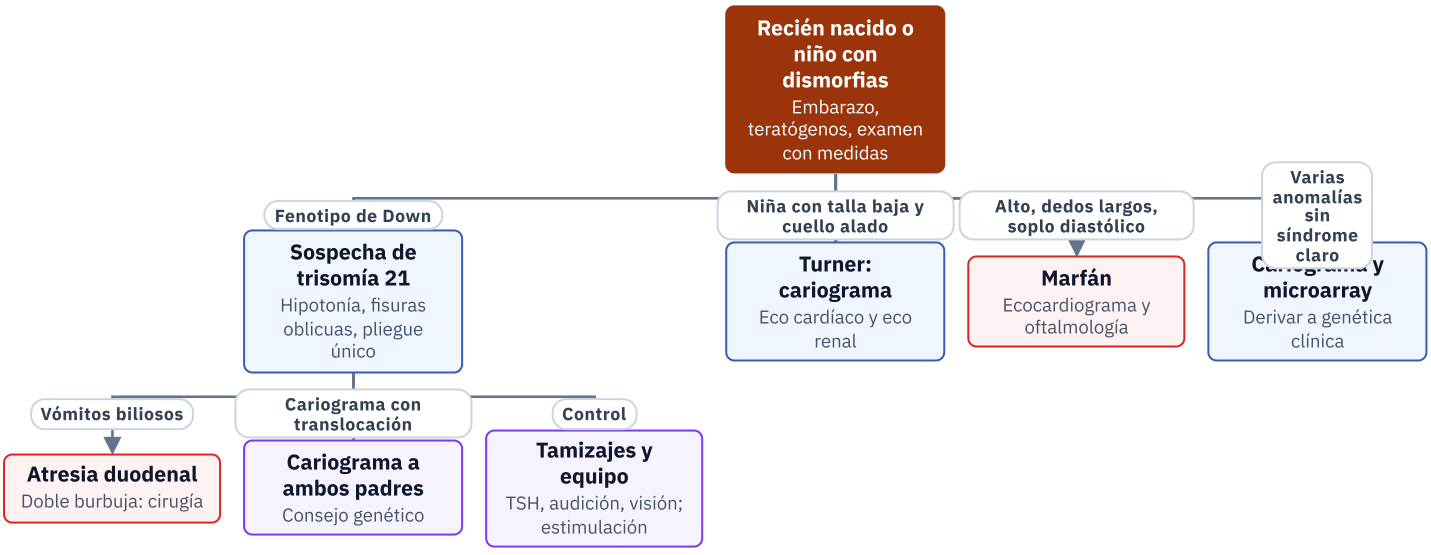


TABLA 18.26 · SÍNDROMES GENÉTICOS FRECUENTES: FENOTIPO CLAVE Y EXAMEN DE CONFIRMACIÓN

SÍNDROME	ALTERACIÓN	FENOTIPO Y COMPLICACIONES CLAVE	ESTUDIO
Down	Trisomía 21	Hipotonía, fisuras palpebrales oblicuas, pliegue palmar único · canal AV, atresia duodenal, hipotiroidismo	Cariograma · ecocardiograma · TSH
Turner	45,X	Talla baja, cuello alado, linfedema, coartación aórtica · amenorrea primaria	Cariograma · ecocardiograma · ecografía renal
Klinefelter	47,XXY	Varón alto, testículos pequeños, ginecomastia · infertilidad	Cariograma · testosterona
Marfán	Mutación FBN1 (AD)	Talla alta, aracnodactilia, hiperlaxitud, luxación del cristalino · dilatación aórtica	Criterios de Ghent · ecocardiograma · oftalmología
Prader-Willi	Deleción 15q11-13 paterna	Hipotonía neonatal, luego hiperfagia y obesidad · retraso cognitivo	Estudio de metilación
Alcohólico fetal	Teratógeno (alcohol)	Microcefalia, fisuras palpebrales cortas, filtrum liso, labio superior delgado	Clínico · antecedente materno

REGLA DE ORO — **Tres o más anomalías menores: buscar una mayor** — Cariograma; microarray si hay malformaciones múltiples

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Pediatría General**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 18.26 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · CRECIMIENTO, DESARROLLO & VACUNAS PNI

18.28 Pediatría Psicosocial: Maltrato Infantil, Entrevista Clínica, Conductas de Riesgo en el Adolescente y Psiquiatría de Enlace

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
2 preguntas reales 2013–2025

2.01.1.138 Maltrato infantil — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Entrevista y comunicación efectiva · Prevención de conductas de riesgo · Psiquiatría de enlace

LO QUE TE PREGUNTAN

- La combinación de relato inconsistente, equimosis en un lactante, fracturas costales posteriores y hematoma subdural es maltrato hasta demostrar lo contrario: se busca hemorragia retiniana con fondo de ojo.
- El personal de salud tiene obligación legal de denunciar el maltrato y los delitos que conozca dentro de **24 horas** (art. 175 del Código Procesal Penal) y se solicita medida de protección al Tribunal de Familia.
- En menores de **2 años** con sospecha de maltrato se solicita serie esquelética; el estudio incluye coagulación para descartar causas médicas.
- **Comunicación de malas noticias**: protocolo SPIKES, en un lugar privado, explorando qué saben y quieren saber, con lenguaje simple y empatía; ambos padres tienen derecho a ser informados.
- En el adolescente la entrevista es confidencial (HEADSSS) y el consumo de sustancias se tamiza con CRAFFT, con intervención breve motivacional.



QUEMADURA EN CALCETÍN
Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., Fig. 17.2B

ALGORITMO · SOSPECHA DE MALTRATO Y APOYO PSICOSOCIAL

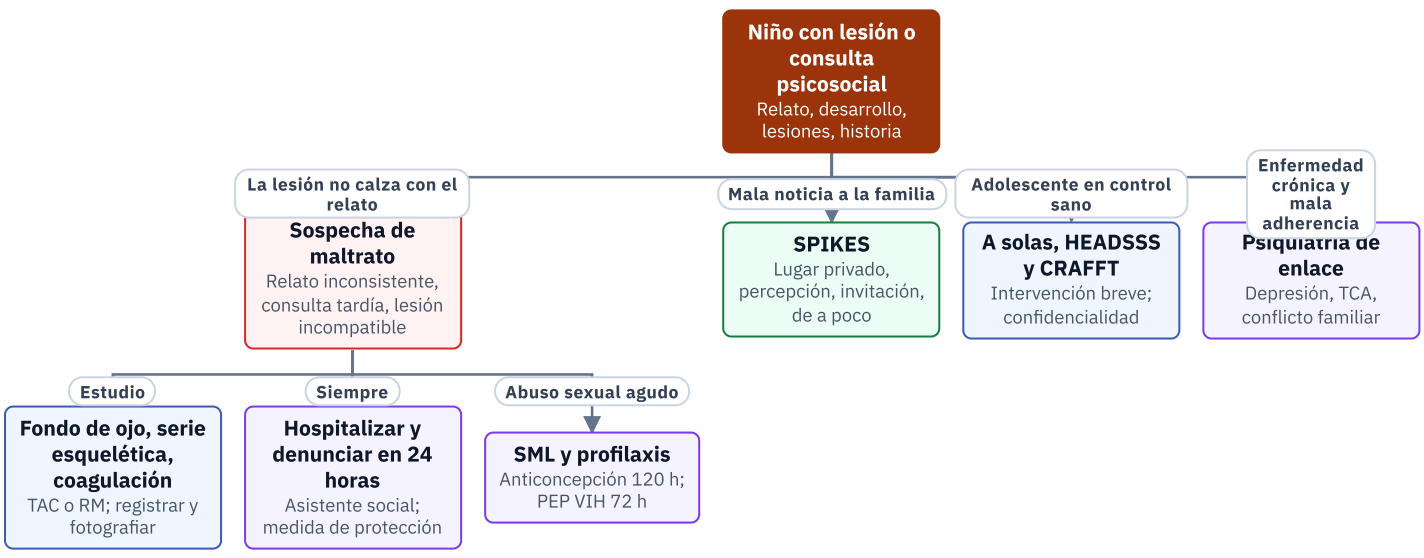


TABLA 18.28 · LESIONES Y SIGNOS SUGERENTES DE MALTRATO INFANTIL

HALLAZGO	POR QUÉ ES SOSPECHOSO	ESTUDIO	CONDUCTA
Equimosis en lactante o en cara, oído, cuello, tórax, abdomen, nalgas	Las zonas protegidas y la edad sin deambulación hacen improbable el trauma accidental	Coagulación y plaquetas	Registro, protección y denuncia
Fracturas costales posteriores, metafisarias en esquina, múltiples de distinta edad	Mecanismo de sacudida, compresión o torsión	Serie esquelética (< 2 años)	Hospitalizar y denunciar
Hematoma subdural + hemorragias retinianas	Síndrome del niño sacudido	Fondo de ojo · TAC / resonancia	UCI / neurocirugía · denuncia
Quemadura por inmersión («guante», «calcetín») o de cigarrillo	Patrón de contacto forzado, bordes netos	Fotografías · valoración de cuidadores	Hospitalizar y denunciar
Relato inconsistente o consulta tardía	Incompatible con la lesión o con la edad del desarrollo	Entrevistas separadas · asistente social	Proteger al niño

REGLA DE ORO **Relato que no calza: sospechar** — Subdural + costillas posteriores + equimosis

PRACTICA **Libro Gordo Pediatría General**, pregunta **85** (pág. 24) · solucionario pág. 36.

Clase 18.28 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · RESPIRATORIO PEDIÁTRICO & URGENCIAS

18.5 Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
8 preguntas reales 2013–2025

2.01.1.020 **Bronquiolitis** — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

También: Síndrome bronquial obstructivo · Crisis bronquial obstructiva · Oxigenoterapia · Coqueluche · Gases en sangre arterial · Serología y técnicas de aislamiento viral y bacteriano · Detección de agentes virales por inmunofluorescencia

LO QUE TE PREGUNTAN

- **El Score de Tal clasifica el SBO en**: Leve (**≤ 5**), Moderado (6-8) y Severo (9-12).
- SBO Moderado (Tal 6-8) requiere Hospitalización Abreviada con Salbutamol 2 puff c/**10 min** por **1 hora**.
- Si al término de la 1.ª hora persiste en Tal 6-8, se agrega Prednisona oral **1-2 mg/kg** y se inicia 2.ª hora de Salbutamol.
- Falla de **2 horas** de hospitalización abreviada o Tal inicial **≥ 9 es** indicación de hospitalización formal.
- VRS es el agente etiológico principal; Nirsevimab se administra a recién nacidos como profilaxis pasiva universal.



DIFICULTAD RESPIRATORIA
Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 52

ALGORITMO · BRONQUIOLITIS Y SBO: EL SCORE DECIDE LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

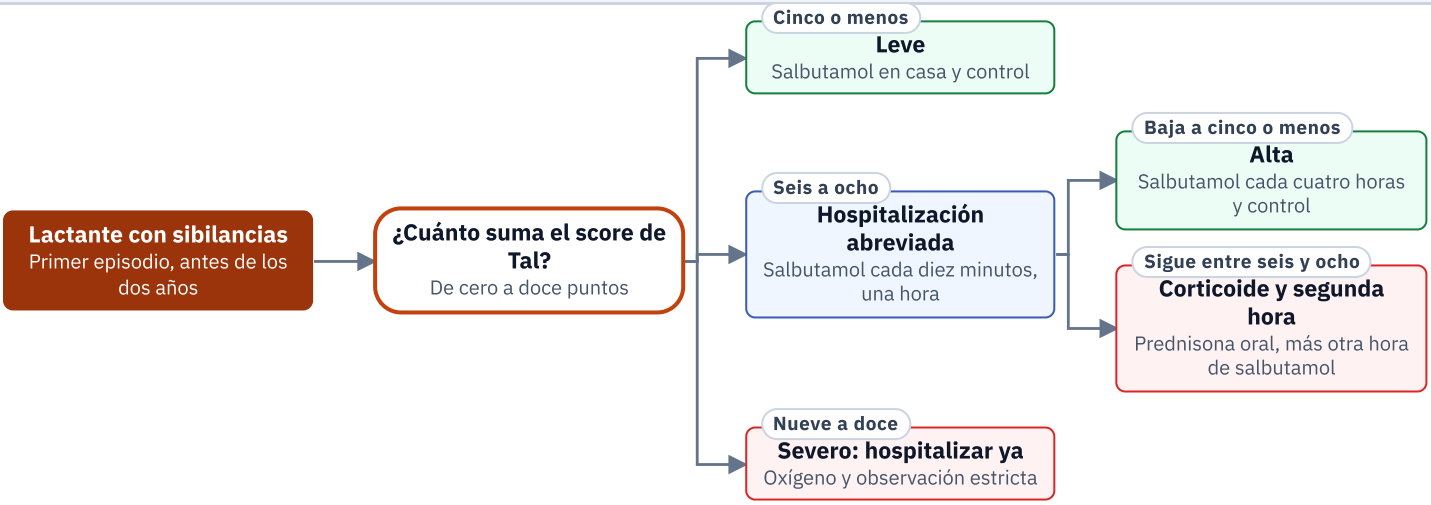


TABLA 18.5 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL ESTRIDOR Y OBSTRUCCIÓN RESPIRATORIA EN EL LACTANTE

ENTIDAD CLÍNICA	FRECUENCIA / EDAD	CLÍNICA CARDINAL	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Bronquiolitis / SBO	< 2 años (pico 2-6 meses)	Sibilancias espiratorias, estertores, polipnea	Oxígeno, Salbutamol si responde, KNT
Laringitis Aguda (Croup)	6 meses a 3 años	Estridor inspiratorio, tos perruna, disfonía	Dexametasona oral + Adrenalina racémica
Cuerpo Extraño	1 a 3 años	Inicio súbito, asfixia inicial, sibilancias unilaterales	Broncoscopía rígida urgente
Traqueítis Bacteriana	1 a 6 años	Fiebre alta, aspecto tóxico, estridor bifásico	Cefotaxima EV + Intubación en UCI
Laringomalacia	Congénita (1-4 semanas)	Estridor inspiratorio que cede en prono	Observación / Maduración espontánea

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Score de Tal cinco o menos	Salbutamol en casa y control	Hospitalizar sin necesidad
Score entre seis y ocho	Hospitalización abreviada, una hora	Hospitalizar de entrada sin probar
Persiste moderado tras la hora	Corticoide oral y segunda hora	Repetir salbutamol sin corticoide

REGLA DE ORO **Cinco o menos** — Casa, con salbutamol

PRACTICA **Libro Gordo Pediatría General**, preguntas **12–18, 53, 74, 90** (págs. 14–15, 20, 23, 25) · solucionario págs. 27–28, 32, 35, 37.

Clase 18.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · RESPIRATORIO PEDIÁTRICO & URGENCIAS

18.6 Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona

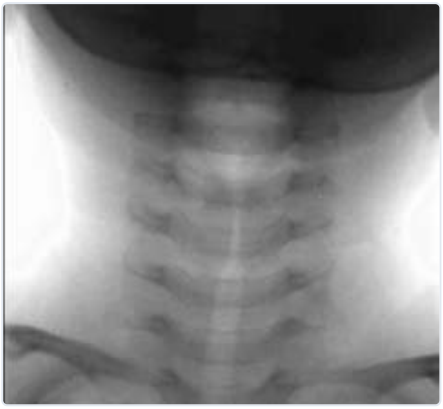
★☆☆ PRIORIDAD BAJA
2 preguntas reales 2013–2025

2.01.1.025 Laringitis — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Estridor · Obstrucción de vía aérea superior

LO QUE TE PREGUNTAN

- **La tríada clínica del Croup es**: Disfonía + Tos perruna + Estridor inspiratorio nocturno.
- El agente causal principal es el Virus Parainfluenza tipo 1.
- **Grado I**: Estridor solo al llorar; Grado II: Estridor continuo en reposo; Grado III: Estridor con tiraje severo; Grado IV: Agotamiento.
- La Dexametasona oral (**0.15 a 0.6 mg/kg**) está formalmente indicada en TODOS los grados de laringitis.
- La adrenalina nebulizada se indica en Grados II moderados-graves y Grado III.
- Todo paciente que recibe adrenalina nebulizada debe permanecer en observación un mínimo de **2 horas** por efecto rebote.



SIGNO DEL CAMPANARIO
Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 3220

ALGORITMO · CROUP: DEL GRADO CLÍNICO AL TRATAMIENTO

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

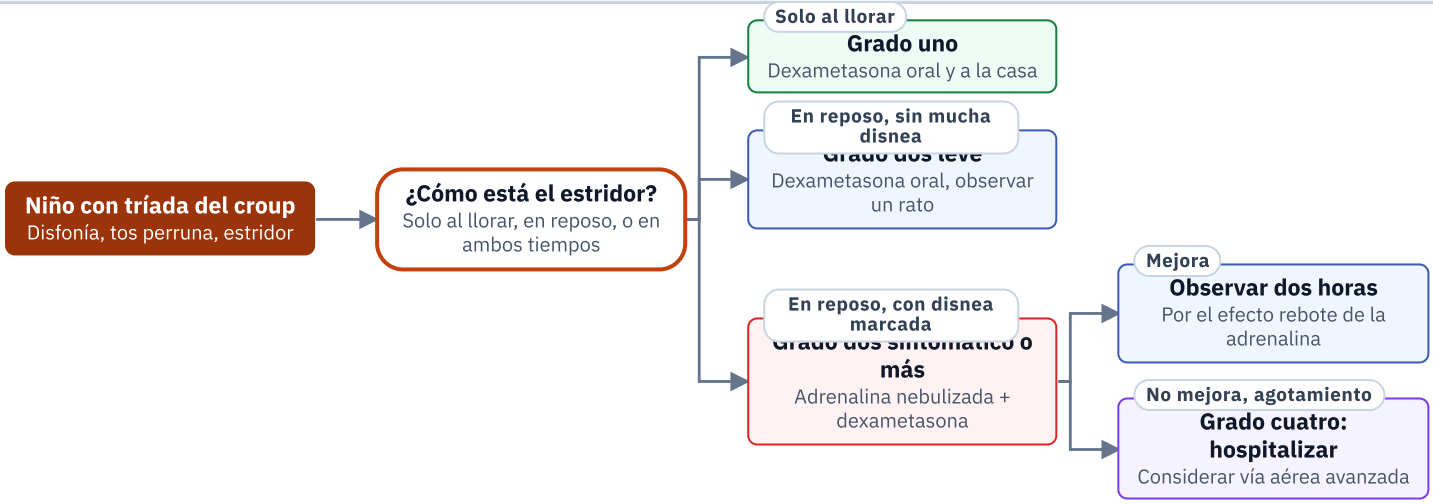


TABLA 18.6 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL ESTRIDOR LARÍNGEO AGUDO

PATOLOGÍA	ETIOLOGÍA PRINCIPAL	FIEBRE / TOXICIDAD	SIGNOS CLÍNICOS DISTINTIVOS	CONDUCTA INMEDIATA
Laringitis Viral (Croup)	Parainfluenza tipo 1	Febrícula / Estado general conservado	Tos perruna, disfonía, estridor nocturno	Dexametasona VO ± Adrenalina nebulizada
Epiglotitis Aguda	Haemophilus influenzae b / S. pyogenes	Fiebre muy alta / Tóxico séptico	Sialorrea, posición en trípode, sin tos	Asegurar vía aérea en pabellón + Cefotaxima
Traqueítis Bacteriana	Staphylococcus aureus	Fiebre alta / Tóxico progresivo	Croup refractario a adrenalina, pus traqueal	Intubación orotraqueal + Cloxacilina/Cefotaxima
Cuerpo Extraño Laríngeo	Aspiración mecánica	Apirético / Súbito	Crisis de asfixia al comer o jugar, afonía	Maniobras de desobstrucción / Laringoscopía

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Estridor solo con el llanto	Dexametasona oral y a la casa	No tratar por ser leve
Estridor en reposo, con disnea	Adrenalina nebulizada y dexametasona	Dar solo dexametasona y esperar
Recibió adrenalina, mejoró rápido	Observar al menos dos horas	Dar el alta de inmediato

REGLA DE ORO **Disfonía, tos perruna, estridor** — Ese es el croup

PRACTICA **Libro Gordo Pediatría General**, preguntas **26, 54** (págs. 16, 20) · solucionario págs. 29, 32.

Clase 18.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · RESPIRATORIO PEDIÁTRICO & URGENCIAS

18.7 Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización

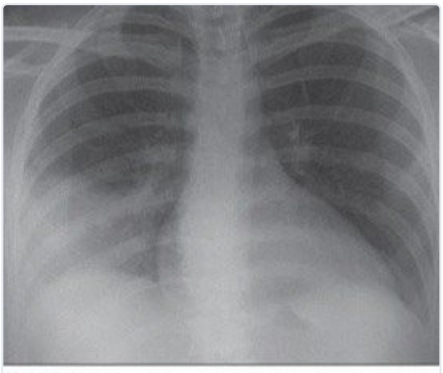
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
10 preguntas reales 2013–2025

2.01.1.024 Infecciones respiratorias agudas bajas y sus complicaciones — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Radiografía de tórax

LO QUE TE PREGUNTAN

- La taquipnea en reposo es el signo cardinal más sensible de neumonía en niños con tos y fiebre según la OMS.
- **Umbrales OMS de taquipnea**: <2m: **≥60 rpm**; 2-11m: **≥50 rpm**; **1-4 años**: **≥40 rpm**; **≥5 años**: **≥30 rpm**.
- El antibiótico de 1.ª línea ambulatorio es la Amoxicilina oral a **80-90 mg/kg**/día por **7 días**.
- Dosis altas de amoxicilina son necesarias para vencer la resistencia intermedia de Streptococcus pneumoniae.
- En niños hospitalizados sin complicaciones, la primera línea es Ampicilina EV (**150-200 mg/kg**/día).



NEUMONÍA LOBAR
Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 345

ALGORITMO · NEUMONÍA EN EL NIÑO: DE LA TAQUIPNEA AL ANTIBIÓTICO

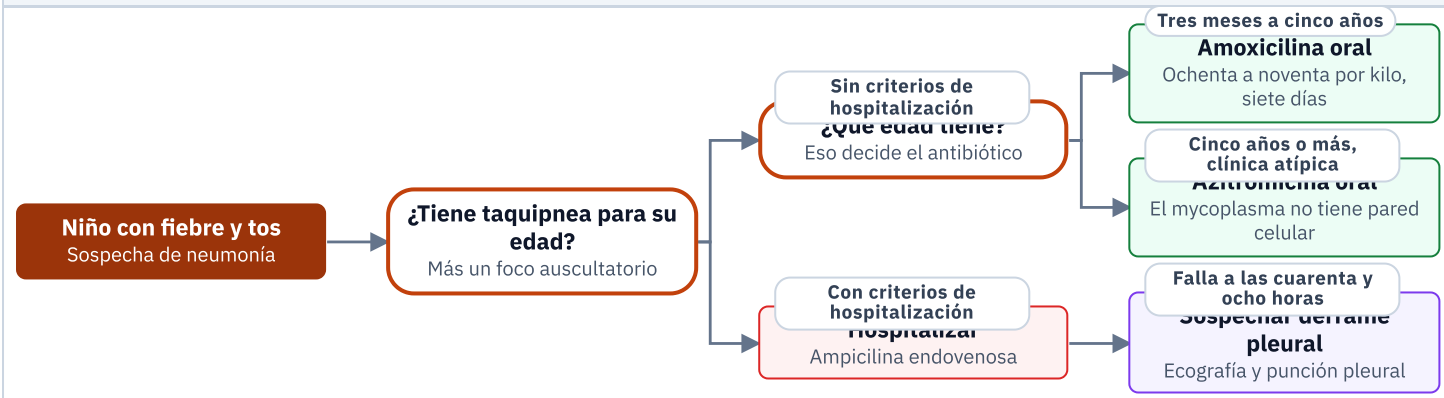


TABLA 18.7 · ETIOLOGÍA Y ANTIBIOTICOTERAPIA EMPÍRICA DE LA NEUMONÍA SEGÚN GRUPO ETARIO

EDAD DEL PACIENTE	PATÓGENOS BACTERIANOS PRINCIPALES	ANTIBIÓTICO DE 1.ª ELECCIÓN	VÍA Y DOSIS
< 1 mes (Neonato)	S. agalactiae, E. coli, Listeria	Ampicilina + Cefotaxima (o Amika)	EV hospitalizado
1 a 3 meses febril	S. pneumoniae, S. agalactiae, VRS	Ampicilina + Cefotaxima EV	EV hospitalizado siempre
3 meses a 5 años	S. pneumoniae (Neumococo)	Amoxicilina oral	Oral: 80 - 90 mg/kg/día c/8-12h x 7 días
Hospitalizado (>3m)	S. pneumoniae sensible/intermedio	Ampicilina EV	EV: 150 - 200 mg/kg/día c/6h
> 5 años (Escolar)	Mycoplasma pneumoniae / Chlamydia	Azitromicina o Claritromicina	Oral: Azitro 10 mg/kg d1, luego 5 mg/kg d2-5

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Fiebre, tos y taquipnea típica	Diagnóstico clínico, sin radiografía	Pedir radiografía a todos
Neumonía típica, no complicada	Amoxicilina oral en dosis alta	Usar amoxicilina con ácido clavulánico
Escolar con clínica atípica	Azitromicina	Tratar con amoxicilina

REGLA DE ORO **Fiebre, tos y taquipnea** — Diagnóstico clínico, sin radiografía de rutina

PRACTICA **Libro Gordo Pediatría General**, preguntas **27–28** (pág. 16) · solucionario pág. 29.

Clase 18.7 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · RESPIRATORIO PEDIÁTRICO & URGENCIAS

18.8 Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
6 preguntas reales 2013–2025

2.01.2.003 Aspiración cuerpo extraño — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Maniobra de Heimlich · Obstrucción de vía aérea superior · Fibrobroncoscopía · Aspiración de cuerpo extraño con asfixia · Aspiración de cuerpo extraño sin asfixia

LO QUE TE PREGUNTAN

- Si el paciente tose con fuerza (obstrucción parcial), solo se estimula a toser; no se interviene.
- **En menores de 1 año con obstrucción total**: 5 golpes interescapulares + 5 compresiones torácicas.
- La maniobra de Heimlich está estrictamente PROHIBIDA en menores de 1 año (riesgo de rotura hepática).
- La maniobra de Heimlich es de elección en niños mayores de 1 año y adultos.
- Nunca realizar barrido con el dedo a ciegas en la cavidad oral (puede empujar el objeto más profundo).
- Si cae inconsciente, se inicia RCP y solo se extrae el objeto si está visible directamente en la boca.



BRONQUIO DERECHO
Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 59

ALGORITMO · CUERPO EXTRAÑO EN LA VÍA AÉREA: LA EDAD DECIDE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

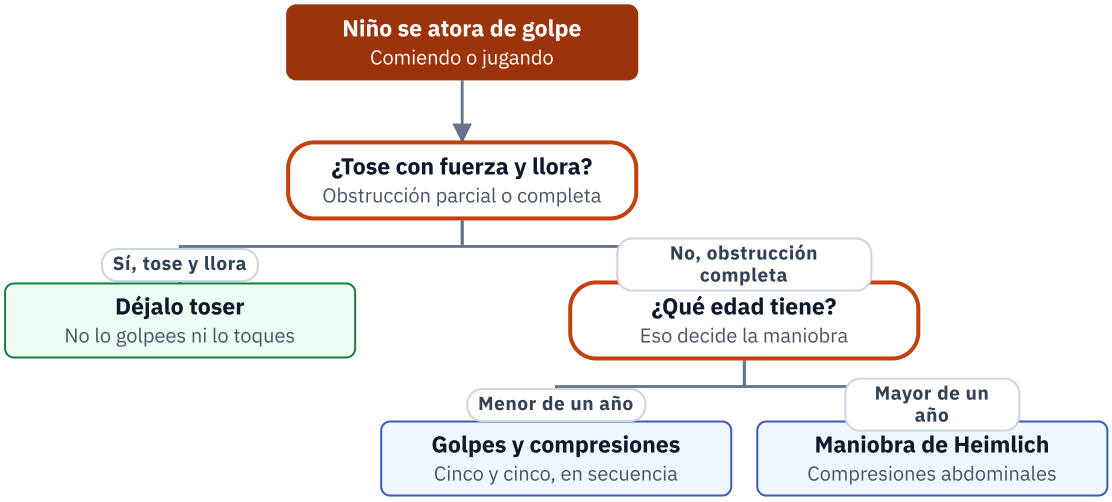


TABLA 18.8 · DIFERENCIAS EN EL MANEJO DE OVACE SEGÚN GRUPO ETARIO (AHA / AAP)

PARÁMETRO	LACTANTE (< 1 AÑO)	NIÑO MAYOR (> 1 AÑO) Y ADULTO
Posición del Paciente	Boca abajo sobre antebrazo inclinado hacia abajo	De pie o sentado inclinado levemente hacia adelante
Maniobra 1	5 golpes interescapulares con el talón de la mano	5 compresiones abdominales (Heimlich)
Maniobra 2	5 compresiones torácicas con dos dedos en esternón	Compresiones continuas hacia adentro y arriba
Maniobra de Heimlich	¡ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADA! (Riesgo hepático)	Maniobra de elección absoluta
Pérdida de Conciencia	Iniciar RCP: 30:2 (15:2 si 2 rescatadores) + Mirar antes de ventilar	Iniciar RCP convencional
Barrido digital a ciegas	¡ESTRICTAMENTE PROHIBIDO en todas las edades!	¡ESTRICTAMENTE PROHIBIDO!

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Tose con fuerza, todavía llora	Dejarlo toser, no tocarlo	Darle golpes en la espalda
Obstrucción completa, menor de un año	Golpes en la espalda y compresiones torácicas	Maniobra de Heimlich
Obstrucción completa, mayor de un año	Maniobra de Heimlich	Golpes en la espalda como única maniobra

REGLA DE ORO **Menor de un año** — Golpes en la espalda y compresiones torácicas

PRACTICA **Libro Gordo Pediatría General**, preguntas **29–31** (págs. 16–17) · solucionario págs. 29–30.

Clase 18.8 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · RESPIRATORIO PEDIÁTRICO & URGENCIAS

18.23 Cardiología Pediátrica: Soplos, Insuficiencia Cardíaca, Arritmias, Endocarditis y Electrocardiograma

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
6 preguntas reales 2013–2025

2.01.1.054 Soplos — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Insuficiencia cardíaca · Insuficiencia cardíaca. Edema pulmonar · Arritmias · Endocarditis infecciosa · Electrocardiograma

LO QUE TE PREGUNTAN

- Un soplo inocente es sistólico, ≤ II/VI, vibratorio, sin frémito, con segundo ruido normal y en un niño asintomático; no requiere estudio.
- **Son signos de soplo patológico**: diastólico, holosistólico, ≥ III/VI, frémito, click, S2 fijo o único, cianosis, pulsos femorales débiles o insuficiencia cardíaca.
- La insuficiencia cardíaca del lactante se presenta con cansancio al mamar, taquipnea, hepatomegalia y mal incremento ponderal; el manejo inicial es furosemida EV y oxígeno si hay hipoxemia.
- En la taquicardia supraventricular (FC > 220 con QRS estrecho): maniobras vagales y adenosina **0,1 mg/kg** si está estable; cardioversión sincronizada 0,5 a 1 J/kg si está inestable.
- En la endocarditis infecciosa se toman al menos 3 hemocultivos antes de los antibióticos y luego ecocardiograma; la profilaxis dental es solo para cardiopatías de alto riesgo.

ALGORITMO · SOPLO O SOSPECHA DE CARDIOPATÍA EN EL NIÑO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



TABLA 18.23 · SOPLO INOCENTE VS SOPLO PATOLÓGICO EN EL NIÑO

CARACTERÍSTICA	SOPLO INOCENTE	SOPLO PATOLÓGICO	CONDUCTA
Intensidad y momento	≤ II/VI, sistólico, corto	≥ III/VI, holosistólico o diastólico	Inocente: tranquilizar · Patológico: ecocardiograma
Frémito / click	Ausente	Presente (estenosis valvulares)	Derivar a cardiología
Segundo ruido	Normal, con desdoblamiento fisiológico	Único, fuerte o con desdoblamiento fijo (CIA)	ECG y ecocardiograma
Variación	Cambia con la posición, fiebre o ejercicio	Fijo	Registrar y controlar
Síntomas y examen	Asintomático, pulsos normales, crecimiento normal	Cianosis, hepatomegalia, mal incremento, pulsos femorales débiles	Estudio completo y derivación
Ejemplos	Still, flujo pulmonar, zumbido venoso	CIV, CIA, DAP, estenosis, coartación, Fallot	GES si la cardiopatía es operable

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	INOCENTE	PATOLÓGICO	CONDUCTA
Lactante con cansancio al mamar, hepatomegalia	No es bronquiolitis	Insuficiencia cardíaca	Furosemida y ecocardiograma

REGLA DE ORO **Inocente: sistólico, ≤ II/VI, sin frémito** — Niño sano: sin estudio

PRACTICA **Libro Gordo Pediatría General**, preguntas **40, 45** (págs. 18–19) · solucionario pág. 31.

Clase 18.23 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · RESPIRATORIO PEDIÁTRICO & URGENCIAS

18.24 Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica, Intoxicaciones y Prevención de Accidentes

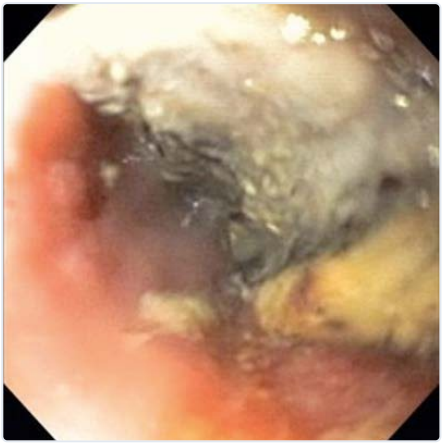
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
6 preguntas reales 2013–2025

2.01.2.020 Paro cardiorrespiratorio — Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar

También: Reanimación cardiopulmonar pediátrica · Intoxicaciones · Prevención de accidentes

LO QUE TE PREGUNTAN

- El paro pediátrico suele ser secundario a hipoxia o shock; el ritmo más frecuente es no desfibrilable (asistolia o AESP), y se trata con RCP de calidad y adrenalina **0,01 mg/kg** cada **3 a 5 minutos**.
- Compresiones de al menos un tercio del tórax, 100 a 120/min; relación 30:2 con un reanimador y 15:2 con dos; en el lactante, técnica de dos pulgares con manos rodeando el tórax.
- **Desfibrilación pediátrica**: 2 J/kg, luego 4 J/kg; amiodarona **5 mg/kg** en la FV/TV refractaria.
- En el síndrome colinérgico se usa atropina hasta secar secreciones y pralidoxima; en el paracetamol, N-acetilcisteína; en opioides, naloxona.
- **Ante cáusticos no se induce vómito ni se neutraliza**: ayuno y endoscopía digestiva alta en **12 a 48 horas**.



LESIÓN ESOFÁGICA GRAVE
Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., Fig. 373.3 (pila de botón)

ALGORITMO · NIÑO GRAVE O INTOXICADO

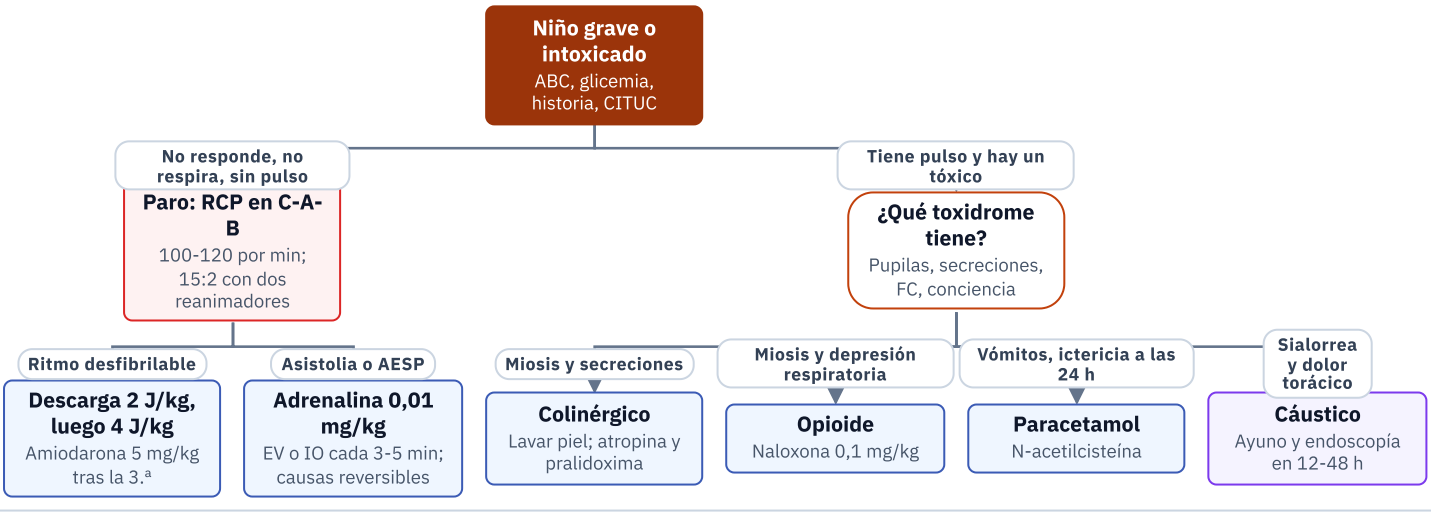


TABLA 18.24 · INTOXICACIONES FRECUENTES: TOXIDROME, CLAVE CLÍNICA Y ANTÍDOTO

TÓXICO / TOXIDROME	CLAVE CLÍNICA	TRATAMIENTO ESPECÍFICO	ADVERTENCIA
Organofosforados / colinérgico	Miosis, sialorrea, broncorrea, bradicardia, fasciculaciones	Atropina (hasta secar secreciones) + pralidoxima; descontaminar piel	El personal debe protegerse del contacto
Paracetamol	Asintomático 24 h; luego ictericia y alza de transaminasas	N-acetilcisteína · nivel a las 4 h (Rumack-Matthew)	Dosis tóxica > 150 mg/kg; tratar aunque haya daño hepático
Opioides	Miosis, depresión respiratoria, coma	Naloxona 0,1 mg/kg (máx. 2 mg)	Su vida media es corta: puede haber renarcotización
Salicilatos	Taquipnea, tinnitus, fiebre, acidosis metabólica	Alcalinizar orina · hemodiálisis si es grave	Evitar intubar sin hiperventilar
Cáusticos	Sialorrea, dolor torácico o abdominal, estridor	Ayuno + endoscopía digestiva alta en 12-48 h	No inducir vómito ni neutralizar
Monóxido de carbono	Cefalea, compromiso de conciencia, saturación normal	Oxígeno 100% · cámara hiperbárica si es grave	La oximetría de pulso es falsamente normal

REGLA DE ORO **Paro del niño: hipoxia o shock** — Asistolia o AESP; adrenalina 0,01 mg/kg

PRACTICA **Libro Gordo Pediatría General**, preguntas **46, 65** (págs. 19, 22) · solucionario págs. 31, 34.

Clase 18.24 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INFECCIONES, EXANTEMAS & DIGESTIVO PEDIÁTRICO

18.9 Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo

★☆☆
PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

2.01.1.017 Síndrome febril agudo sin foco — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Proteína C reactiva cuantitativa

LO QUE TE PREGUNTAN

- Todo recién nacido < **28 días** con fiebre (**≥ 38.0**°C) se hospitaliza y se estudia completamente con punción lumbar.
- El esquema antibiótico neonatal empírico es Ampicilina + Cefotaxima (o Gentamicina) endovenosa.
- Entre los 29 y **90 días** se utilizan los Criterios de Rochester para seleccionar pacientes de bajo riesgo.
- **Criterios de Rochester de laboratorio**: Leucocitos 5.000-15.000, baciliformes < 1.500, orina < 10 leucocitos/campo.
- Si cumple TODOS los criterios de Rochester, puede manejarse ambulatorio con control obligatorio en **24 horas**.
- En lactantes de **3 a 36 meses**, la infección bacteriana grave más frecuente es la ITU (orina por cateterismo).

ALGORITMO · FIEBRE SIN FOCO: LA EDAD DECIDE LA CONDUCTA

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

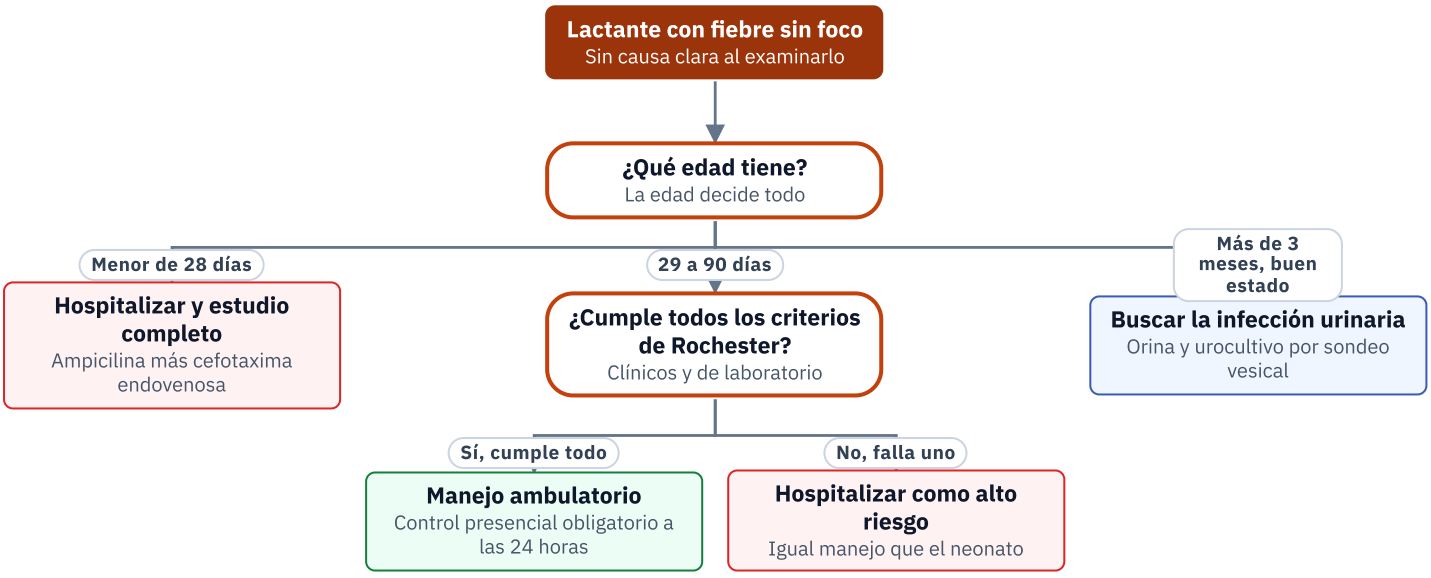


TABLA 18.9 · ESTRATIFICACIÓN DE CONDUCTA EN LACTANTE FEBRIL SIN FOCO SEGÚN EDAD

EDAD DEL LACTANTE	RIESGO DE IBG	EXÁMENES REQUERIDOS	CONDUCTA MÉDICA INMEDIATA
< 28 días (Neonato)	10 - 15% (Muy Alto)	Hemograma, PCR, Hemocultivos, Orina sondeo, Punción Lumbar (LCR), Rx	Hospitalización obligatoria + Ampicilina + Cefotaxima EV
29 a 90 días (Rochester (+))	< 1% (Bajo Riesgo)	Hemograma, Sedimento urinario/Urocultivo	Manejo ambulatorio + Control presencial a las 24 horas
29 a 90 días (Rochester (-))	> 10% (Alto Riesgo)	Punción Lumbar, Hemocultivos, Orina sondeo, Laboratorio	Hospitalización + Antibióticos EV empíricos
> 3 meses (Buen estado)	< 2% (Riesgo Menor)	Orina completa y Urocultivo si T° > 39°C o persistente	Ambulatorio con signos de alarma y control SOS

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Neonato con buen aspecto	Hospitalizar y estudio completo igual	Confiarse del buen aspecto clínico
29 a 90 días con un criterio alterado	Hospitalizar como alto riesgo	Mandarlo a la casa porque se ve bien
Fiebre después de los 3 meses	Orina completa y urocultivo por sondeo	Pedir solo hemograma y esperar

REGLA DE ORO **Menor de 28 días** — Siempre hospitalizar y estudio completo

PRACTICA **Libro Gordo Pediatría General**, preguntas **5–6, 32–36, 71–72, 84** (págs. 13, 17, 23–24) · solucionario págs. 26, 30, 34, 36.

Clase 18.9 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INFECCIONES, EXANTEMAS & DIGESTIVO PEDIÁTRICO

18.10 Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)

★★★ PRIORIDAD ALTA
38 preguntas reales 2013–2025

2.01.1.009 Exantemas virales — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Escarlatina · Vasculitis: PSH, Kawasaki, otros

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Exantema súbito (HHV-6)**: Fiebre alta **3 días** que desaparece bruscamente y aparece el exantema en tronco.
- **Eritema infeccioso (Parvovirus B19)**: Signo de la bofetada en mejillas seguido de exantema reticular en encaje.
- **Escarlatina (S. pyogenes)**: Exantema en 'piel de lija', signo de Pastia, lengua en fresa; requiere Penicilina x **10 días**.
- **Varicela (VVZ)**: Exantema vesicular polimorfo pruriginoso con lesiones en todos los estadios ('cielo estrellado').
- **Kawasaki**: Fiebre **≥ 5 días** + 4/5 criterios (conjuntivitis no purulenta, labios rojos fisurados, adenopatía >**1.5cm**, exantema, edema manos/pies).



EXANTEMA SÚBITO
Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 101

ALGORITMO · EXANTEMAS INFANTILES: LA FIEBRE TE DA LA PISTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



TABLA 18.10 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LOS PRINCIPALES EXANTEMAS INFANTILES

ENFERMEDAD	AGENTE ETIOLÓGICO	RELACIÓN FIEBRE - EXANTEMA	MORFOLOGÍA DEL EXANTEMA	SIGNO / CLAVE DIAGNÓSTICA
Exantema Súbito	Herpesvirus Humano 6 (HHV-6)	Fiebre cae bruscamente y aparece exantema	Maculopapular rosado en tronco	Lactante 6-18 meses · Buen estado general
Eritema Infeccioso	Parvovirus B19	Afebril o febrícula leve	Bofetada facial + encaje reticular	Exacerbación con sol/calor · Escolar
Escarlatina	Streptococcus pyogenes (SGA)	Fiebre alta simultánea al exantema	Micropapular difuso 'piel de lija'	Signo de Pastia · Lengua aframbuesada
Varicela	Virus Varicela Zóster (VVZ)	Fiebre moderada simultánea	Vesículas ('gota de rocío') polimorfas	Patrón en cielo estrellado · Prurito intenso
Enfermedad de Kawasaki	Idiopática / Vasculitis	Fiebre ≥ 5 días obligatoria	Exantema polimorfo no vesicular	Inyección conjuntival, labios fisurados, IgEV

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

CUADRO	LA FIEBRE Y EL EXANTEMA	ERROR FRECUENTE
Sarampión	Tres C y Koplik, luego exantema que baja	No notificar ni dar vitamina A
Rubéola	Leve, con adenopatías retroauriculares	Vacunar a la embarazada

REGLA DE ORO **La fiebre cae, sale el exantema** — Es exantema súbito

PRACTICA **Libro Gordo Pediatría General**, preguntas **47–48, 67** (págs. 19, 22) · solucionario págs. 31–32, 34.

Clase 18.10 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INFECCIONES, EXANTEMAS & DIGESTIVO PEDIÁTRICO

18.11 Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico

★★★ PRIORIDAD ALTA
15 preguntas reales 2013–2025

2.01.1.039 Diarrea aguda y en vías de prolongación — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Deshidratación · Síndrome hemolítico urémico · Síndrome disentérico · Osteoclisis

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Deshidratación moderada (Plan B)**: Niño irritable, ojos hundidos, bebe con avidez y signo del pliegue < 2 segundos.
- **Plan B OMS**: SRO a **50-100 mL/kg** en **4 horas** por vía oral fraccionada.
- Si hay vómitos incoercibles en Plan B, se instala Sonda Nasogástrica para gastroclisis (**20 mL/kg**/hora).
- **Deshidratación severa / shock (Plan C)**: Ringer Lactato o SF **0.9%** endovenoso a **100 mL/kg** (o bolo **20 mL/kg** en shock).
- **Plan A ambulatorio**: Continuar alimentación habitual + SRO **10 mL/kg** post cada deposición líquida.



PLIEGUE PERSISTENTE
Wikimedia Commons «LowSkinTurgor.jpg», CC BY-SA 4.0, DRobert

ALGORITMO · DIARREA AGUDA: LA CLÍNICA DECIDE EL PLAN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



TABLA 18.11 · EVALUACIÓN CLÍNICA DEL GRADO DE DESHIDRATACIÓN SEGÚN LA OMS

SIGNO CLÍNICO	SIN DESHIDRATACIÓN (< 5%)	ALGÚN GRADO / MODERADA (5-10%)	GRAVE / SEVERA (> 10%)
Estado de Conciencia	Alerta, despierto, reactivo	Inquieto, irritable	Letárgico, comatoso, inconsciente
Ojos	Normales	Hundidos	Muy hundidos y secos
Lágrimas	Presentes	Escasas o ausentes	Totalmente ausentes
Boca y Lengua	Húmedas	Secas / Pastosas	Muy secas, saliva filante
Sed	Bebe normal, sin sed excesiva	Sediento, bebe con avidez	Bebe mal o incapaz de beber
Pliegue Cutáneo	Se recupera de inmediato	Desaparece lentamente (< 2 seg)	Desaparece muy lentamente (> 2 seg)
Plan de Manejo OMS	PLAN A (Domicilio)	PLAN B (SRO 50-100 mL/kg en 4h)	PLAN C (Ringer Lactato EV 100 mL/kg)

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Deshidratación moderada	Plan B: sales orales en 4 horas	Pasar suero endovenoso de entrada
Vómitos incoercibles en plan B	Sonda nasogástrica para gastroclisis	Ir directo a la vía endovenosa
Diarrea con sangre y compromiso renal	Sospechar síndrome hemolítico urémico	Dar antibióticos para la diarrea

REGLA DE ORO **Sin deshidratación** — Plan A, en la casa, sin dejar de comer

PRACTICA **Libro Gordo Pediatría General**, preguntas **49–50** (pág. 20) · solucionario pág. 32.

Clase 18.11 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INFECCIONES, EXANTEMAS & DIGESTIVO PEDIÁTRICO

18.12 Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP) vs Invaginación Intestinal

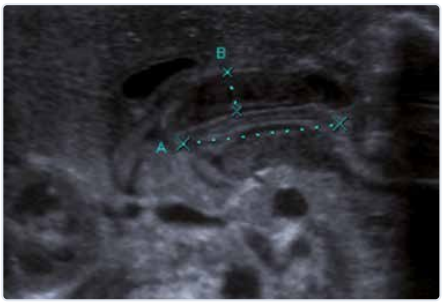
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
8 preguntas reales 2013–2025

2.01.1.046 Displasia broncopulmonar / Reflujo gastroesofágico y vómitos del lactante (código repetido en el Perfil oficial) — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Obstrucción intestinal · Abdomen agudo

LO QUE TE PREGUNTAN

- EHP: Vómitos en proyectil no biliosos en varones de **3 a 5 semanas**, con avidez por alimentarse.
- **Trastorno electrolítico de EHP**: Alcalosis metabólica hipoclorémica e hipopotasémica.
- **Confirmación de EHP**: Ecografía pilórica (músculo **≥ 3 mm**, longitud **≥ 14 mm**).
- **Tratamiento de EHP**: Piloromiotomía de Ramstedt, previa corrección obligatoria de la deshidratación y alcalosis.
- **Invaginación intestinal**: Crisis paroxísticas de dolor cólico con encogimiento de piernas, masa en 'morcilla' y heces en 'jalea de grosella'.



PÍLORO ENGROSADO
Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 65

ALGORITMO · VÓMITOS DEL LACTANTE: EDAD Y COLOR DECIDEN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

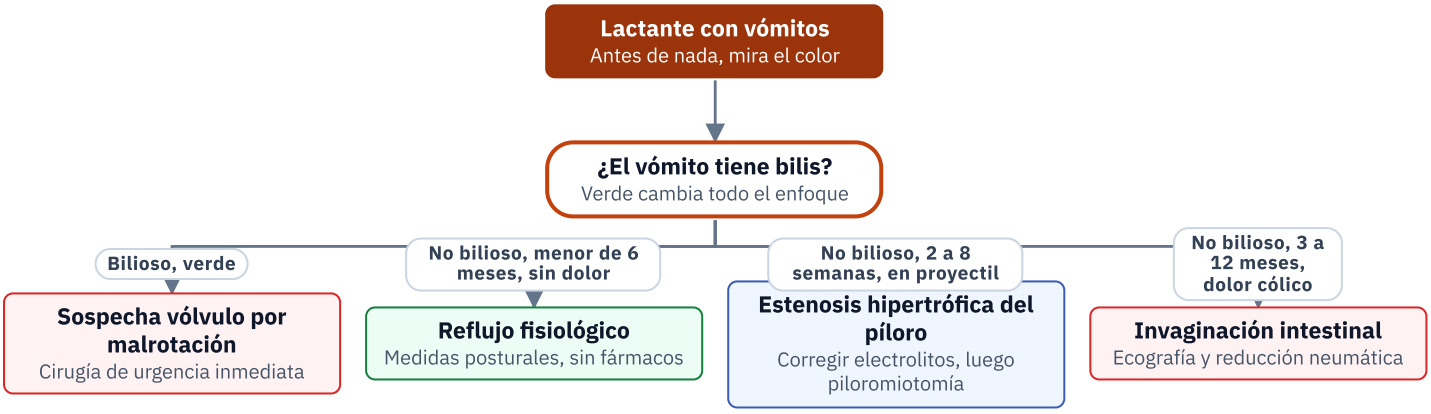


TABLA 18.12 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LOS VÓMITOS QUIRÚRGICOS Y MÉDICOS EN EL LACTANTE

PATOLOGÍA	EDAD TÍPICA	CARACTERÍSTICAS DEL VÓMITO	LABORATORIO / IMÁGENES	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
RGE Fisiológico	< 6 meses	Regurgitación no biliosa, sin dolor	Normal · Buen peso	Medidas posturales · Tranquilizar
Estenosis Hipertrófica del Píloro	3 a 5 semanas	En proyectil, no bilioso, hambre voraz	Alcalosis hipoclorémica · Eco pilórica	Corrección hidroelectrolítica + Piloromiotomía
Invaginación Intestinal	6 a 12 meses	Bilioso tardío, dolor cólico intermitente	Eco en 'diana' · Jalea de grosella	Reducción con enema neumático / Cirugía
Vólvulo por Malrotación	Primer mes	Bilioso precoz y súbito, shock	Rx: escaso gas distal · Tránsito baritado	Cirugía de Ladd inmediata de urgencia
Alergia a Proteína de Leche (APLV)	Primeros meses	Regurgitaciones, irritabilidad, estrías de sangre	Prueba de exclusión materna	Fórmula extensamente hidrolizada

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

CUADRO	CLAVE CLÍNICA	CONDUCTA
Vómito bilioso en el recién nacido	Vólvulo por malrotación hasta descartarlo	Cirugía de urgencia inmediata
Apendicitis (escolar)	Dolor que migra a fosa ilíaca derecha y luego vómitos	Ecografía, ayuno, antibiótico si es complicada, cirugía
Dolor abdominal agudo en cualquier niño	Examinar genitales e ingles	Descartar torsión y hernia

REGLA DE ORO **Bilioso es urgencia** — Vólvulo hasta que lo descartes

PRACTICA **Libro Gordo Pediatría General**, preguntas **51, 57** (págs. 20–21) · solucionario págs. 32–33.

Clase 18.12 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INFECCIONES, EXANTEMAS & DIGESTIVO PEDIÁTRICO

18.13 Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis

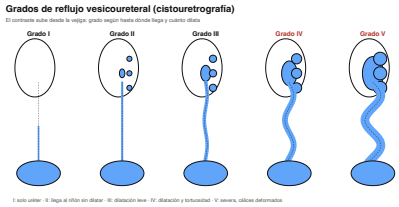
★★★ PRIORIDAD ALTA
16 preguntas reales 2013–2025

2.01.1.062 Infección urinaria — Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar

También: Malformaciones urogenitales · Orina completa · Ecotomografía abdominal · Cultivos y antibiograma · Cateterismo vesical · Punción suprapúbica · Urocultivo y antibiograma · Cintigrama renal · Malformaciones congénitas nefrourológicas · Reflujo vésico ureteral

LO QUE TE PREGUNTAN

- La bolsa recolectora de orina solo sirve para descartar ITU si el sedimento es **100%** normal.
- Para confirmar ITU e iniciar tratamiento en lactantes, la muestra debe ser por sondeo vesical o punción suprapúbica.
- **Urocultivo significativo por sondeo**: **≥ 10.000 a** 50.000 UFC/mL; por chorro medio: **≥ 100.000 UFC/mL**.
- Escherichia coli es el patógeno causal en más del **80%** de los casos.
- En ITU febril ambulatoria se usa Cefadroxilo oral por **7 a 10 días**; en hospitalizados, Cefotaxima EV.
- La Nitrofurantoína está contraindicada en ITU febril / pielonefritis (no alcanza concentraciones tisulares).



GRADOS DEL REFLUJO
Dibujo propio (esquema)

ALGORITMO · INFECCIÓN URINARIA: FIEBRE O NO FIEBRE DECIDE TODO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

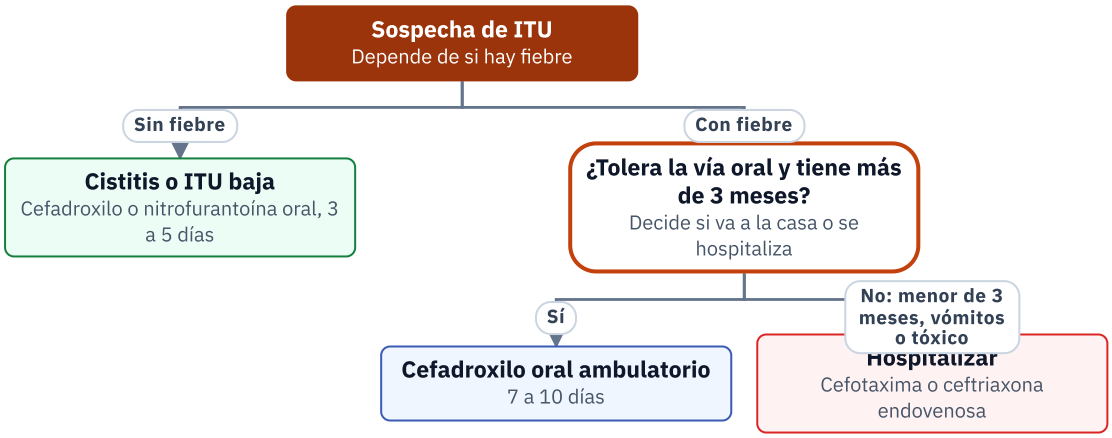


TABLA 18.13 · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE UROCULTIVO SEGÚN TÉCNICA DE RECOLECCIÓN (SOCHIPE / AAP)

MÉTODO DE RECOLECCIÓN	RECUENTO SIGNIFICATIVO (UFC/ML)	INDICACIÓN PRINCIPAL	RIESGO DE FALSO POSITIVO
Punción Suprapúbica	≥ 1 UFC/mL (gramnegativos)	Neonato / Fimosis extrema / Duda	Nulo (Estándar de Oro)
Cateterismo Vesical (Sondeo)	≥ 10.000 a 50.000 UFC/mL	Lactantes sin control de esfínteres	Bajo (< 5%)
Segundo Chorro Limpio	≥ 100.000 UFC/mL (10^5)	Niños con control de esfínteres	Moderado si mala técnica
Bolsa Recolectora	¡NO VÁLIDA para urocultivo!	Solo útil si sedimento es negativo	Extremadamente alto (hasta 85%)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Cistitis sin fiebre	Cefadroxilo o nitrofurantoína oral	Usar nitrofurantoína en la febril
Pielonefritis, buen estado, mayor de 3 meses	Cefadroxilo oral ambulatorio	Hospitalizar a todos por igual
Primer episodio de ITU febril	Ecografía renal y vesical a todos	Pedirla solo si hay síntomas nuevos

REGLA DE ORO **Bolsa recolectora: solo descarta** — Nunca confirma ni trata

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Pediatría General**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 18.13 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INFECCIONES, EXANTEMAS & DIGESTIVO PEDIÁTRICO

18.14 Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
5 preguntas reales 2013–2025

2.01.1.081 Síndrome convulsivo — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

También: Síndrome convulsivo · Punción lumbar

LO QUE TE PREGUNTAN

- La convulsión febril ocurre entre los **6 meses** y **5 años** asociada a fiebre sin infección del SNC.
- **Crisis Simple**: Generalizada, < **15 minutos**, única en **24h**, sin focalidad neurológica (excelente pronóstico).
- **Crisis Compleja**: Focal, > **15 minutos**, repetida en **24h** o con parálisis de Todd postictal.
- La crisis simple NO requiere EEG, TAC de cerebro ni tratamiento antiepiléptico de mantención.
- La punción lumbar está indicada si hay signos meníngeos, letargia prolongada o lactante < **12 meses** no vacunado.
- Los antipiréticos alivian el malestar del niño pero NO han demostrado prevenir la recurrencia de crisis febriles.

ALGORITMO · CONVULSIÓN CON FIEBRE: SIMPLE, COMPLEJA O MENINGITIS

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

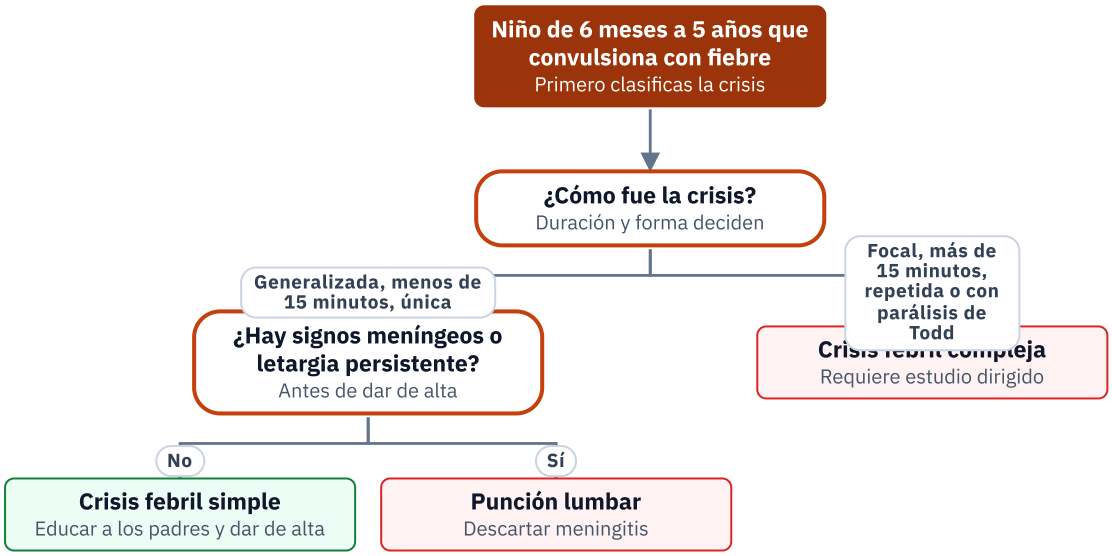


TABLA 18.14 · DIFERENCIAS CLAVE ENTRE CONVULSIÓN FEBRIL SIMPLE Y COMPLEJA

CARACTERÍSTICA	CRISIS FEBRIL SIMPLE (TÍPICA)	CRISIS FEBRIL COMPLEJA (ATÍPICA)
Frecuencia Poblacional	70 a 80% de los casos	20 a 30% de los casos
Semiología Motora	Generalizada tónico-clónica bilateral	Focal o con inicio asimétrico
Duración de la Crisis	< 15 minutos (habitualmente < 5 min)	> 15 minutos (o status si > 30 min)
Episodios en 24 Horas	Único en 24 horas	≥ 2 episodios en 24 horas
Examen Postictal	Normal sin déficit focal	Parálisis de Todd (paresia transitoria)
Estudio (EEG / TAC)	NO indicado de rutina	Indicado según evolución clínica
Riesgo Epilepsia Futura	Bajo (~ 1-2%, similar a basal)	Moderado (5 a 10%)

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Crisis generalizada, menos de 15 minutos, típica	Alta con educación a los padres	Pedir EEG o TAC de rutina
Signos meníngeos o letargia persistente	Punción lumbar	Asumir que es solo la crisis febril
Lactante sin vacunas contra Haemophilus o neumococo	Punción lumbar	No estudiar por parecer benigna

REGLA DE ORO **Simple: generalizada y breve** — Única en 24 horas, sin secuela

PRACTICA **Libro Gordo Pediatría General**, preguntas **52, 86** (págs. 20, 24) · solucionario págs. 32, 36.

Clase 18.14 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INFECCIONES, EXANTEMAS & DIGESTIVO PEDIÁTRICO

18.25 Inmunodeficiencias Primarias, Infecciones Recurrentes, Hepatomegalia e Interpretación del Hemograma Pediátrico

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
2 preguntas reales 2013–2025

2.01.1.056 Inmunodeficiencias — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Infecciones recurrentes · Hepatomegalia · Hemograma

LO QUE TE PREGUNTAN

- Un niño sano de sala cuna presenta 6 a 10 infecciones respiratorias virales al año; si son leves y el crecimiento es normal no se estudia.
- **Son signos de alarma de inmunodeficiencia**: **≥ 2 neumonías** o infecciones profundas, antibióticos EV, gérmenes inusuales, falla de medro, candidiasis persistente y antecedente familiar.
- Las inmunodeficiencias humorales (Bruton) se manifiestan después de los **6 meses** con infecciones sinopulmonares piógenas; el tratamiento es inmunoglobulina de reemplazo.
- Las inmunodeficiencias secundarias (VIH, desnutrición, síndrome nefrótico) son más frecuentes que las primarias; el estudio inicial incluye hemograma, inmunoglobulinas y VIH.
- La hepatomegalia con hipoglicemia de ayuno corto, acidosis láctica e hipertrigliceridemia sugiere glucogenosis tipo I; hay que distinguirla de la ptosis hepática por hiperinsuflación.

ALGORITMO · INFECCIONES RECURRENTES, HEPATOMEGALIA Y HEMOGRAMA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

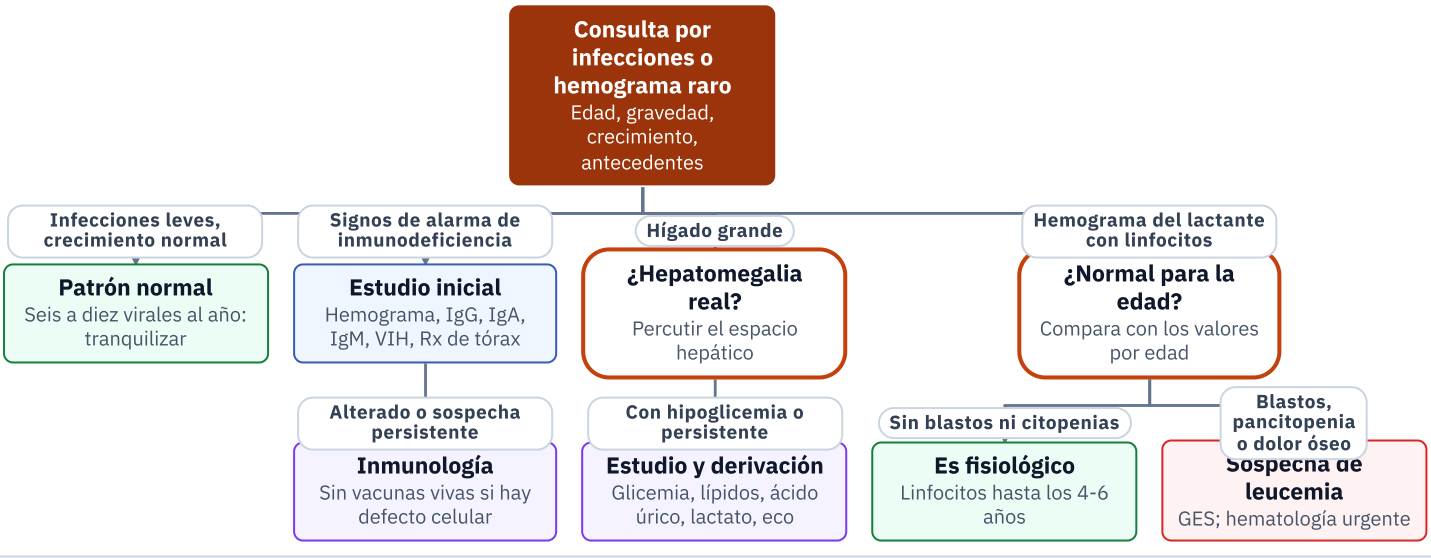


TABLA 18.25 · INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS: COMPARTIMENTO, INFECCIONES TÍPICAS Y EXAMEN DE SOSPECHA

COMPARTIMENTO	INFECCIONES TÍPICAS	EJEMPLOS	EXAMEN ORIENTADOR
Humoral (B)	Otitis, sinusitis y neumonías piógenas desde los 6 meses	Bruton, déficit de IgA, inmunodeficiencia común variable	Inmunoglobulinas IgG, IgA, IgM · linfocitos B CD19
Celular (T) y combinada	Virales graves, hongos, Pneumocystis; diarrea crónica; falla de medro	SCID, DiGeorge, Wiskott-Aldrich	Recuento de linfocitos · Rx de tórax (timo) · subpoblaciones
Fagocitos	Abscesos, adenitis, gérmenes catalasa positivos; caída tardía del cordón	Enfermedad granulomatosa crónica, adhesión leucocitaria	Hemograma · prueba de dihidrorrodamina o NBT
Complemento	Neisseria recurrente, infecciones piógenas	Déficit de C5-C9, C3	CH50 y fracciones C3, C4
Secundarias	Variables	VIH, desnutrición, nefrótico, asplenia, fármacos	Test de VIH · albúmina · hemograma

TRAMPAS EUNACOM

EDAD	HEMOGLOBINA (G/DL)	LEUCOCITOS (/MM³)	FÓRMULA PREDOMINANTE
Recién nacido	14 a 20	9.000 a 30.000	Neutrófilos
2 a 3 meses	9,5 a 12 (nadir)	6.000 a 17.500	Linfocitos

REGLA DE ORO **Niño sano de sala cuna: 6-10 al año** — Leves y con crecimiento normal: sin estudio

PRACTICA **Libro Gordo Pediatría General**, pregunta **59** (pág. 21) · solucionario pág. 33.

Clase 18.25 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · INFECCIONES, EXANTEMAS & DIGESTIVO PEDIÁTRICO

18.27 Uroginecología Pediátrica: Fimosis, Sinequias Vulvares y Enuresis

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
4 preguntas reales 2013–2025

2.01.1.089 Fimosis — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Sinequias vulvares · Enuresis

LO QUE TE PREGUNTAN

- **La fimosis fisiológica del preescolar asintomático no se trata**: aseo suave, sin retracción forzada, y control (el **90%** de los prepucios es retráctil a los **3 años**).
- Constituyen indicación de tratamiento la fimosis sintomática, cicatricial o asociada a balanopostitis o ITU recurrentes: corticoide tópico **4-8 semanas** y circuncisión si falla.
- Las sinequias vulvares asintomáticas o parciales se observan con higiene y lubricación; las completas o sintomáticas usan betametasona tópica **0,05%** por **2-4 semanas**.
- Nunca se separan manualmente ni se operan las sinequias vulvares de rutina.

ALGORITMO · FIMOSIS, SINEQUIA VULVAR Y ENURESIS

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

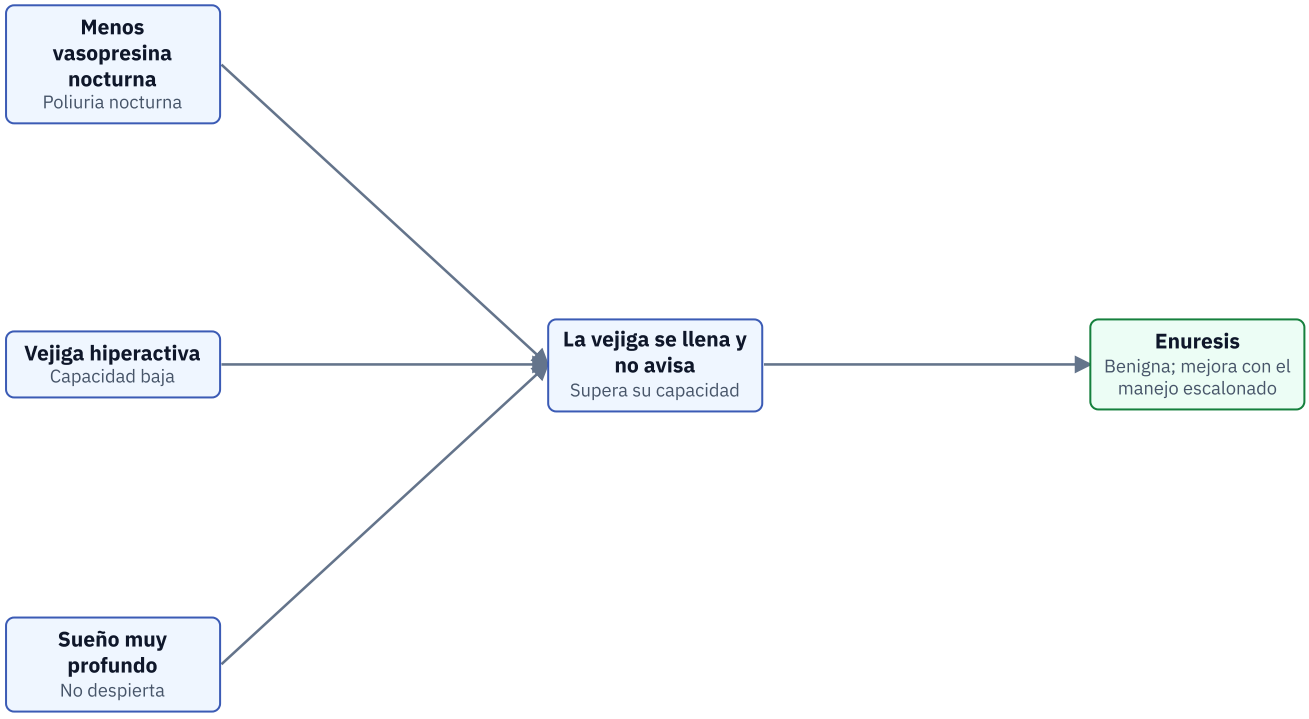


TABLA 18.27 · ALTERACIONES GENITALES PEDIÁTRICAS FRECUENTES: CONDUCTA DEL MÉDICO GENERAL

ENTIDAD	DATO CLAVE	MANEJO	CUÁNDO DERIVAR
Fimosis fisiológica	Preescolar asintomático, prepucio sano y flexible	Aseo suave · NO retraer a la fuerza · control	Si persiste con síntomas o cicatriz
Fimosis sintomática o cicatricial	Anillo fibroso, balanopostitis o ITU recurrente	Betametasona tópica 4-8 semanas	Falla del corticoide o liquen escleroso: circuncisión
Sinequia vulvar parcial	Línea translúcida avascular, asintomática	Higiene + vaselina · observar	ITU recurrente o retención urinaria
Sinequia completa o sintomática	Impide ver el meato o hay goteo / ITU	Betametasona 0,05% 2-4 semanas · luego emoliente	Falla del tratamiento tópico

REGLA DE ORO **Fimosis fisiológica: aseo suave y control** — Nunca retraer a la fuerza

PRACTICA **Libro Gordo Pediatría General**, pregunta **83** (pág. 24) · solucionario pág. 36.

Clase 18.27 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · NEONATOLOGÍA & SALA DE PARTOS

18.15 Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR

★★★ PRIORIDAD ALTA
11 preguntas reales 2013–2025

2.01.5.011 Reanimación neonatal — Realizar

También: Atención inmediata del recién nacido · Asfixia neonatal · Vínculo y apego · Encefalopatía hipóxico-isquémica · Alteraciones de la termorregulación · Atresia coanal congénita

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Tres preguntas iniciales**: ¿A término? ¿Buen tono? ¿Respira o llora? Si todas sí: contacto piel a piel inmediato.
- **Si FC < 100 lpm o apnea a los 60 segundos**: iniciar Ventilación a Presión Positiva (VPP) de inmediato.
- En recién nacidos **≥ 35 semanas**, la VPP se inicia con AIRE AMBIENTAL (FiO2 **21%**), NUNCA con O2 al **100%**.
- El sensor de oximetría de pulso debe colocarse siempre en la mano o muñeca DERECHA (saturación preductal).
- El masaje cardíaco solo se inicia si la FC es < **60 lpm** pese a 30 segundos de VPP efectiva con tubo traqueal.
- **Técnica de masaje**: dos pulgares en el tercio inferior del esternón con relación 3 compresiones por 1 ventilación (3:1).



ALGORITMO DE REANIMACIÓN
Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 8

ALGORITMO · REANIMACIÓN NEONATAL: EL ORDEN QUE DECIDE TODO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

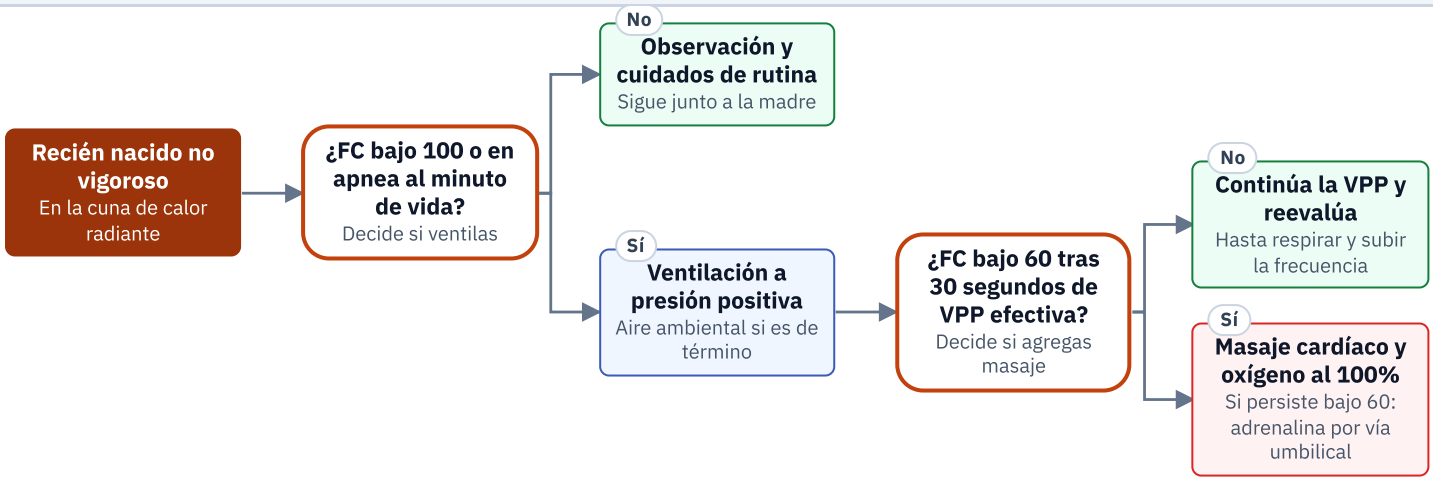


TABLA 18.15 · EVALUACIÓN DEL TEST DE APGAR EN EL RECIÉN NACIDO (MINUTOS 1 Y 5)

SIGNO CLÍNICO	0 PUNTOS	1 PUNTO	2 PUNTOS
A - Apariencia (Color)	Cianosis central o palidez	Cuerpo rosado, acrocianosis	Completamente rosado
P - Pulso (Frecuencia Cardíaca)	Ausente	< 100 latidos por minuto	≥ 100 latidos por minuto
G - Gesticulación (Reflejos)	Sin respuesta al estímulo	Mueca / llanto débil	Llanto vigoroso, tos o estornudo
A - Actividad (Tono Muscular)	Flácido, sin movimiento	Cierta flexión de extremidades	Movimientos activos, tono firme
R - Respiración	Ausente (apnea)	Lenta, irregular, débil	Buena, llanto vigoroso y regular

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
RN de término, FC bajo 100 al minuto	VPP con aire ambiental	Partir con oxígeno al 100%
FC bajo 60 tras VPP mal aplicada	Corregir la técnica primero	Saltar directo al masaje cardíaco
FC bajo 60 tras 30 s de VPP efectiva	Masaje cardíaco en relación 3 a 1	Seguir solo con VPP otros minutos

REGLA DE ORO **FC menor a 100 o apnea** — Inicia VPP de inmediato

PRACTICA **Libro Gordo Pediatría General**, pregunta **68** (pág. 22) · solucionario pág. 34.

Clase 18.15 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · NEONATOLOGÍA & SALA DE PARTOS

18.16 Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
6 preguntas reales 2013–2025

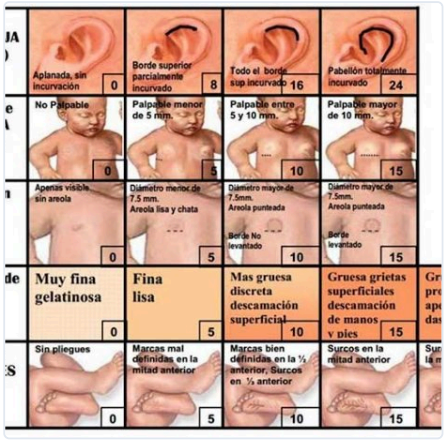
2.01.1.128 RN PEG-GEG

Dx Específico | Tx Completo | Seg Derivar

También: Prematurez · Retinopatía del prematuro

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Término**: **37 a 41 semanas** + **6 días**; Pretérmino: < **37 semanas**; Postérmino: **≥ 42 semanas**.
- **Percentiles de peso**: PEG < P10; AEG P10-P90; GEG > P90.
- El test de Capurro evalúa 5 parámetros somáticos en **≥ 29 semanas**: EG = (puntaje + 204) / 7.
- El test de New Ballard evalúa parámetros somáticos y neuromusculares en prematuros extremos.
- **Complicaciones clásicas de PEG**: Hipoglicemia (falta de reservas), hipotermia y policitemia.
- **Complicaciones clásicas de GEG**: Hipoglicemia (hiperinsulinismo en hijos de madre diabética) y distocia de hombros.



TEST DE CAPURRO
Test de Capurro (esquema docente)

ALGORITMO · CRUZAR EDAD GESTACIONAL Y PESO AL NACER

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

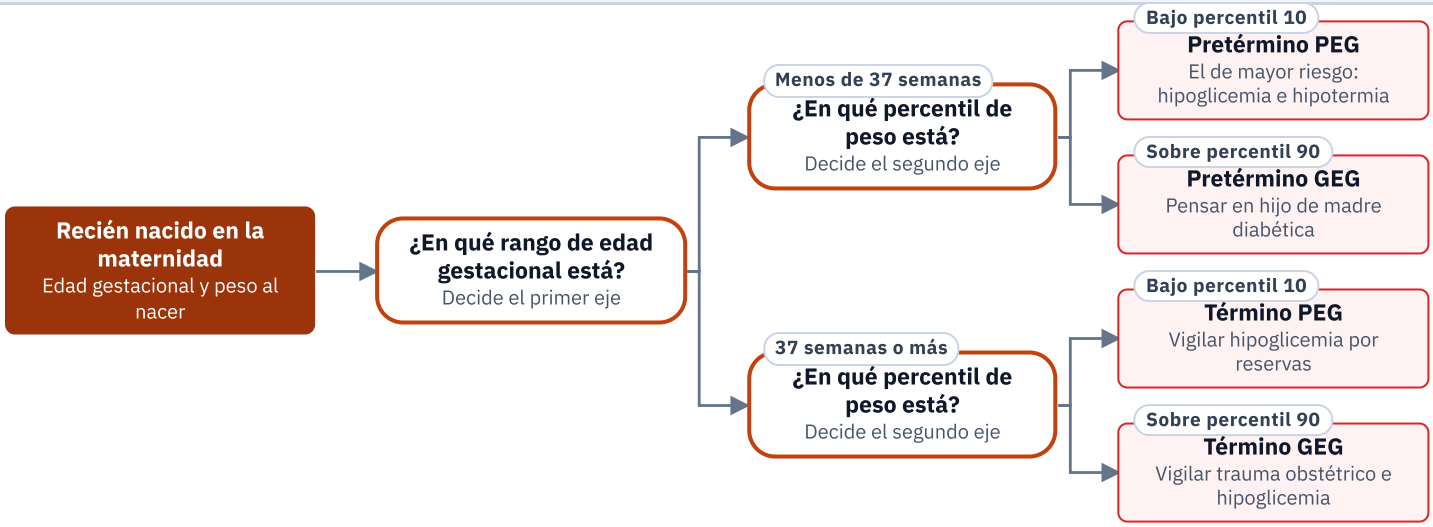


TABLA 18.16 · MATRIZ DE CLASIFICACIÓN NEONATAL SEGÚN EDAD GESTACIONAL Y PERCENTIL DE PESO

CATEGORÍA	EDAD GESTACIONAL (SEMANAS)	PERCENTIL DE PESO INTRAUTERINO	COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES
Pretérmino PEG	< 37 semanas	< P10	Membrana hialina, hipoglicemia severa, hipotermia, enterocolitis
Pretérmino AEG	< 37 semanas	P10 a P90	Dificultad respiratoria (EMH), ictericia, apneas
Pretérmino GEG	< 37 semanas	> P90	Hijo de madre diabética, hipoglicemia por hiperinsulinismo
Término PEG	37 a 41+6 semanas	< P10	Hipoglicemia por falta de depósitos, poliglobulia
Término AEG	37 a 41+6 semanas	P10 a P90	Bajo riesgo neonatal general · Alojamiento conjunto
Término GEG	37 a 41+6 semanas	> P90	Distocia de hombros, fractura clavicular, hipoglicemia
Postérmino	≥ 42 semanas	Cualquier percentil	Aspiración meconial (SAM), oligohidramnios, piel descamada

REGLA DE ORO **Término: 37 a 41 semanas** — Pretérmino antes, postérmino después

PRACTICA **Libro Gordo Pediatría General**, pregunta **69** (pág. 22) · solucionario pág. 34.

Clase 18.16 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · NEONATOLOGÍA & SALA DE PARTOS

18.17 Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia

★★★ PRIORIDAD ALTA
12 preguntas reales 2013–2025

2.01.1.121 Ictericia neonatal y del primer trimestre — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Pruebas hepáticas

LO QUE TE PREGUNTAN

- Toda ictericia que aparece en las primeras **24 horas** de vida es PATOLÓGICA y de origen HEMOLÍTICO.
- La incompatibilidad ABO ocurre en madres grupo O con hijos grupo A o B (puede ocurrir en el 1.er embarazo).
- La incompatibilidad Rh ocurre en madres Rh(-) con hijos Rh(+) y es mucho más severa.
- La ictericia fisiológica aparece después de las **24 horas** (pico al 3.°-5.° día) y resuelve al día 7-10.
- La ictericia por leche materna (Arias) aparece al final de la 1.ª semana, el niño sube de peso y NO se suspende la lactancia.



ICTERICIA EN LA CARA
Bates' Guide to Physical Examination, p. 848

ALGORITMO · ICTERICIA NEONATAL: CUÁNDO ES PELIGROSA

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción



TABLA 18.17 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE ICTERICIA NEONATAL

ENTIDAD CLÍNICA	MOMENTO DE INICIO	PICO MÁXIMO	MECANISMO PATOGÉNICO	CONDUCTA MÉDICA
Ictericia Hemolítica (ABO/Rh)	< 24 horas de vida	Primeras 24-48 horas	Destrucción de hematíes mediada por anticuerpos	Fototerapia inmediata ± IgEV o Exanguinotransfusión
Ictericia Fisiológica	> 24 horas (días 2-3)	Días 3 a 5 (7-10 en preter)	Inmadurez de glucuroniltransferasa + hematocrito alto	Observación / Fototerapia solo si supera curvas
Ictericia por Falta de Lactancia	Días 2 a 5	Día 4 a 6	Deshidratación + aumento de circulación enterohepática	Optimizar técnica de lactancia · Corregir peso
Ictericia por Leche Materna	Días 5 a 7 (Tardía)	Semanas 2 a 3	Factores de la leche que inhiben conjugación	Tranquilizar a los padres · Mantener lactancia
Atresia de Vías Biliares	> 2 semanas (persistente)	Progresivo	Colestasia obstructiva (Bilirrubina Directa > 20%)	Acolia, coluria · Derivar urgente a Cirugía (Kasai)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Ictericia antes de las 24 horas	Hospitalizar y estudiar hemólisis	Esperar a ver si es fisiológica
Madre Rh positiva, hijo Rh negativo	No hay incompatibilidad Rh	Pensar en incompatibilidad Rh igual
Fisiológica, bebé sano y activo	Reforzar lactancia y control ambulatorio	Pedir estudio de hemólisis sin motivo

REGLA DE ORO **Antes de las 24 horas** — Patológica y hemolítica

PRACTICA **Libro Gordo Pediatría General**, pregunta **70** (pág. 22) · solucionario pág. 34.

Clase 18.17 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · NEONATOLOGÍA & SALA DE PARTOS

18.18 Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM

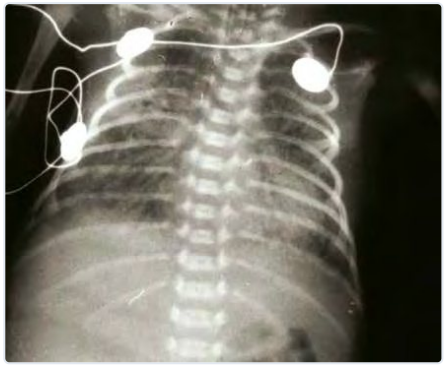
★☆☆ PRIORIDAD BAJA
3 preguntas reales 2013–2025

2.01.1.126 Síndrome distress respiratorio — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Síndrome aspirativo meconial · Prematurez · Enfermedad pulmonar crónica · Apneas

LO QUE TE PREGUNTAN

- En el Score de Silverman-Andersen, 0 es normal y 10 es máxima gravedad (lo inverso de APGAR).
- EMH: Prematuros (< 34 sem), quejido precoz, Rx con volúmenes disminuidos, vidrio esmerilado y broncograma.
- **Tratamiento de EMH**: CPAP nasal precoz + Surfactante exógeno endotraqueal.
- **TTNR**: Nacidos por cesárea sin trabajo de parto, taquipnea superficial, Rx hiperinsuflada con cisuritis, autolimitada en **72h**.
- SAM: Término o postérmino con meconio espeso, Rx con hiperinsuflación e infiltrados algodonosos en parches.



MEMBRANA HIALINA
Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 19

ALGORITMO · DIFICULTAD RESPIRATORIA NEONATAL: EMH, TTNR Y SAM

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

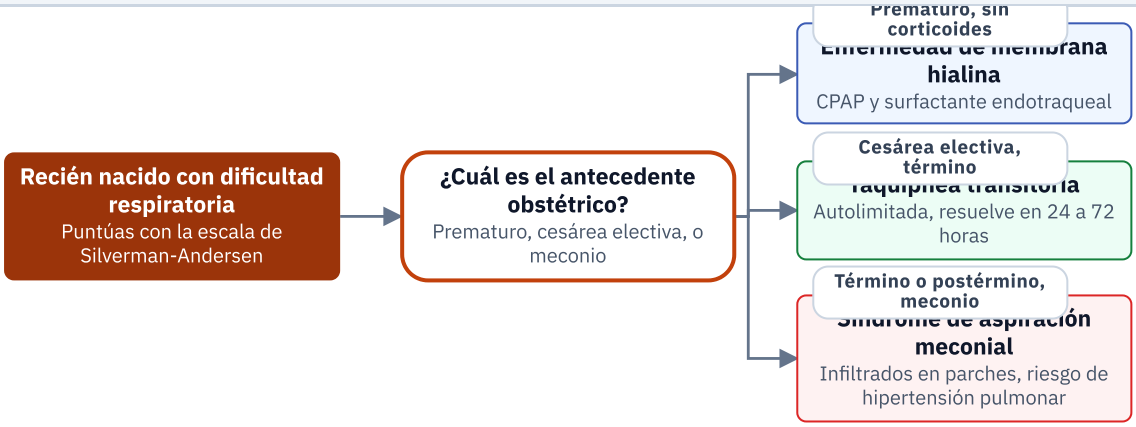


TABLA 18.18 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO Y RADIOLÓGICO DE LA DIFICULTAD RESPIRATORIA NEONATAL

PARÁMETRO	MEMBRANA HIALINA (EMH)	TAQUIPNEA TRANSITORIA (TTNR)	ASPIRACIÓN MECONIAL (SAM)
Edad Gestacional	Prematuro (< 34-35 semanas)	Término o prematuro tardío	Término y Postérmino (≥ 41-42 sem)
Factor Obstétrico	Falta de maduración pulmonar	Cesárea electiva sin trabajo de parto	Sufrimiento fetal crónico / Asfixia
Momento de Inicio	Inmediato / < 2 horas	Inmediato / Primeras horas	Inmediato en sala de partos
Quejido y Tiraje	Quejido intenso, tiraje acentuado	Leve o ausente (taquipnea pura)	Muy intenso, quejido audible
Volumen Pulmonar en Rx	Hipoinsuflado (< 7 espacios)	Hiperinsuflado (> 8 espacios)	Marcadamente hiperinsuflado
Patrón Radiológico	Vidrio esmerilado + broncograma aéreo	Cisuritis + congestión hiliar ('sol')	Infiltrados algodonosos en parches
Evolución Clínica	Empeora hasta día 3 sin surfactante	Resuelve en 24 a 72 horas (Benigna)	Grave · Riesgo de neumotórax y HPPN
Tratamiento Clave	CPAP nasal precoz + Surfactante endotraqueal	Oxígeno bajo flujo / Soporte · Autolimitado	Soporte intensivo, surfactante, óxido nítrico

TRAMPAS EUNACOM

ANTECEDENTE	DIAGNÓSTICO	ERROR FRECUENTE
Prematuro sin corticoides, pulmón hipoinsuflado	Membrana hialina	Confundir con taquipnea transitoria
Cesárea electiva, pulmón hiperinsuflado	Taquipnea transitoria	Dar surfactante sin necesitarlo
Postérmino con meconio espeso	Aspiración meconial	Olvidar el riesgo de hipertensión pulmonar

REGLA DE ORO — **Prematuro sin corticoides** — Membrana hialina

PRACTICA **Libro Gordo Pediatría General**, pregunta **63** (pág. 21) · solucionario pág. 33.

Clase 18.18 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · NEONATOLOGÍA & SALA DE PARTOS

18.19 Sepsis Neonatal: Precoz (< 72 h) vs Tardía (> 72 h), Esquema Ampicilina + Aminoglucósido y Cefotaxima

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

2.01.1.124 Sepsis neonatal — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Sepsis precoz (< 72h)**: Transmisión vertical; patógenos principales: Streptococcus agalactiae y E. coli.
- **Factores de riesgo**: Corioamnionitis materna, RPM > **18 horas** y colonización EGB sin profilaxis.
- En neonatos, la hipotermia (< **36.5°C**) es un signo de infección bacteriana grave más frecuente que la fiebre.
- Leucopenia (< 5.000/mm³) e índice inmaduros/totales (I/T) > 0.20 son marcadores hematológicos cardinales.
- **Esquema antibiótico de elección en sepsis precoz**: Ampicilina + Gentamicina (o Cefotaxima si sospecha meningitis).
- La ampicilina es obligatoria para cubrir Listeria monocytogenes (resistente natural a cefalosporinas).

ALGORITMO · SEPSIS NEONATAL: PRECOZ VERSUS TARDÍA

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

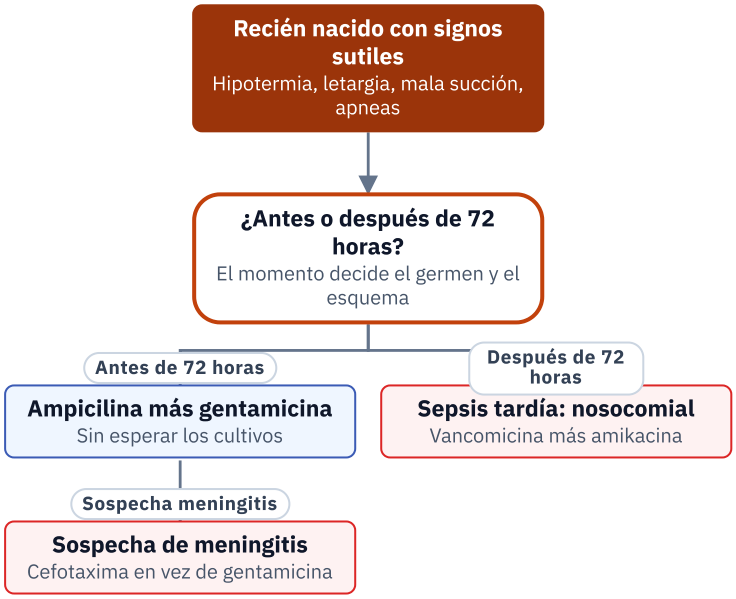


TABLA 18.19 · DIFERENCIAS CARDINALES ENTRE SEPSIS NEONATAL PRECOZ Y TARDÍA

CARACTERÍSTICA	SEPSIS PRECOZ (< 72 HORAS)	SEPSIS TARDÍA (> 72 HORAS)
Mecanismo de Infección	Transmisión vertical intraparto (ascendente)	Transmisión nosocomial (catéteres) o comunitaria
Patógenos Principales	Streptococcus agalactiae (EGB) y E. coli	Staphylococcus epidermidis, S. aureus, Klebsiella
Factores de Riesgo	Corioamnionitis, RPM > 18h, colonización EGB	Prematurez, catéter venoso central, ventilación
Presentación Típica	Fulminante, dificultad respiratoria, shock	Insidiosa, apneas, intolerancia digestiva, meningitis
Antibiótico 1.ª Línea	Ampicilina + Gentamicina (o Cefotaxima)	Vancomicina + Amikacina (o Cefepime/Meropenem)
Mortalidad Relativa	Alta (15 a 30% en prematuros)	Moderada (10 a 15%)

TRAMPAS EUNACOM

SITUACIÓN	SOSPECHA	ESQUEMA
Antes de 72 horas, RPM o corioamnionitis	Sepsis precoz, transmisión vertical	Ampicilina más gentamicina
Sospecha de meningitis asociada	Cambia el aminoglucósido	Ampicilina más cefotaxima
Después de 72 horas, en UCIN	Sepsis tardía, nosocomial	Vancomicina más amikacina

REGLA DE ORO **Antes de las 72 horas** — Vertical: estreptococo y E. coli

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Pediatría General**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 18.19 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · NEONATOLOGÍA & SALA DE PARTOS

18.20 Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
2 preguntas reales 2013–2025

2.01.1.120 Hipoglicemia — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Hipocalcemia · Hijo madre diabética · Convulsiones neonatales · Poliglobulia

LO QUE TE PREGUNTAN

- Se define hipoglicemia neonatal con glicemia < **45 mg/dL** (< **40 mg/dL** en primeras **4 horas**).
- **Los grupos de riesgo son**: Hijos de madre diabética, PEG, GEG, prematuros y asfícticos.
- **Hipoglicemia sintomática**: Bolo EV de Suero Glucosado al **10%** a **2 mL/kg** en **5 minutos**.
- Tras el bolo, se indica infusión continua con carga de glucosa de **6 a 8 mg/kg**/minuto.
- Nunca utilizar bolos de glucosa al **20%** o **50%** (riesgo de hiperosmolaridad e hiperinsulinismo rebote).
- La hipocalcemia sintomática se trata con Gluconato de Calcio al **10%** a **1-2 mL/kg** EV lento con monitor cardíaco.

ALGORITMO · HIPOGLICEMIA NEONATAL: SÍNTOMAS O NO

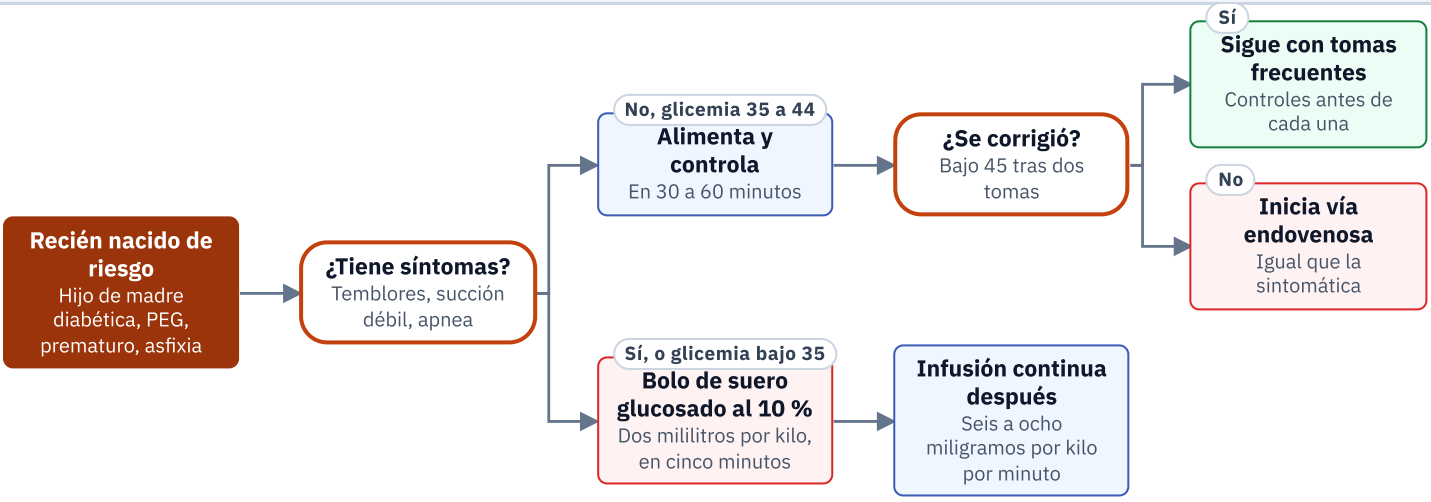


TABLA 18.20 · PROTOCOLO DE MANEJO DE HIPOGLICEMIA NEONATAL SEGÚN CLÍNICA Y NIVEL DE GLICEMIA

ESTADO CLÍNICO	NIVEL DE GLICEMIA PLASMÁTICA	INTERVENCIÓN INICIAL	MONITOREO Y AJUSTE
Asintomático leve	35 a 44 mg/dL	Alimentar al pecho o fórmula (5-10 mL/kg)	Control en 30-60 min · Si falla -> EV
Asintomático refractario	< 45 mg/dL tras 2 tomas	Infusión EV continua SG10% a 4-6 mg/kg/min	Titular para mantener glicemia > 50 mg/dL
Sintomático (temblores)	< 45 mg/dL	Bolo SG10% 2 mL/kg EV + VIG 6-8 mg/kg/min	Control en 30 min · Escalar VIG si persiste baja
Severa / Convulsión	< 25-30 mg/dL	Bolo SG10% 2 mL/kg EV rápido + VIG 8 mg/kg/min	Hospitalización en UCIN · Descartar hiperinsulinismo
Hiperinsulinismo refractario	Requiere VIG > 12 mg/kg/min	Glucagón IM/EV (0.1 mg/kg) o Diazóxido	Estudio endocrinológico especializado

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Riesgo, sin síntomas, glicemia 35–44	Alimentar y controlar en 30–60 min	Pasar suero de entrada
Síntomas o glicemia bajo 35	Bolo de suero glucosado al 10 % + infusión	Solo alimentar y esperar
Cualquier bolo de glucosa	Siempre al 10 %	Usar suero al 20 % o al 50 %

REGLA DE ORO **Sin síntomas, 35 a 44** — Alimentas y controlas en 30 a 60 minutos

PRACTICA **Libro Gordo Pediatría General**, preguntas **87–88** (pág. 25) · solucionario pág. 36.

Clase 18.20 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · NEONATOLOGÍA & SALA DE PARTOS

18.21 Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo

★★★ PRIORIDAD ALTA
11 preguntas reales 2013–2025

2.01.1.075 Hipotiroidismo — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Hipoacusia neonatal · Cardiopatías congénitas frecuentes · Detección de hipoacusia y sordera en niños · Emisiones otoacústicas

LO QUE TE PREGUNTAN

- El tamizaje en papel filtro (TSH y Fenilalanina) se toma entre las 40 y **48 horas** de vida al alta de maternidad.
- Para pesquisar PKU, el recién nacido DEBE haber recibido alimentación proteica láctea por al menos **24-48 horas**.
- El **95%** de los recién nacidos con Hipotiroidismo Congénito son completamente asintomáticos al nacer.
- **Signos tardíos de hipotiroidismo**: Fontanela posterior amplia (> **0.5 cm**), macroglosia, llanto ronco y hernia umbilical.
- **Confirmación de hipotiroidismo**: TSH y T4 libre en sangre venosa; tratamiento: Levotiroxina oral (**10-15 mcg**/kg/d).



HIPOTIROIDISMO SIN TRATAR
Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 4372

ALGORITMO · TAMIZAJE NEONATAL: QUÉ SE BUSCA Y CUÁNDO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

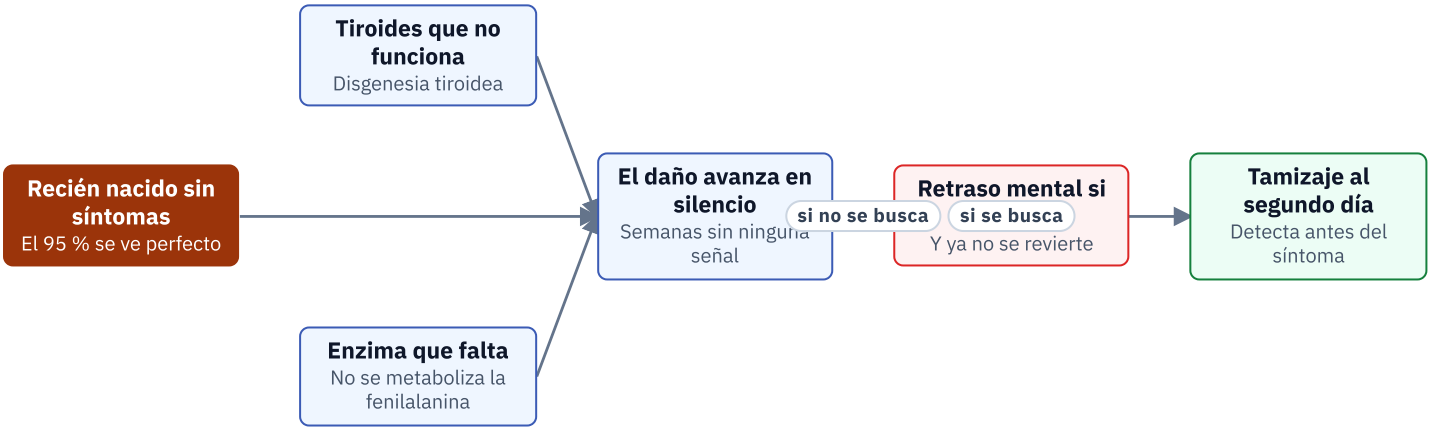


TABLA 18.21 · PROGRAMAS DE TAMIZAJE NEONATAL UNIVERSAL EN MATERNIDADES DE CHILE (MINSAL)

PATOLOGÍA PESQUISADA	MÉTODO DE TAMIZAJE	MOMENTO ÓPTIMO	PRUEBA CONFIRMATORIA	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Hipotiroidismo Congénito	TSH en papel filtro (talón)	40 a 48 horas de vida (alta)	TSH y T4 libre venosa plasmática	Levotiroxina oral 10-15 mcg/kg/día
Fenilcetonuria (PKU)	Fenilalanina en papel filtro	> 40-48h (con aporte lácteo)	Fenilalanina cuantitativa en INTA	Fórmula y dieta libre de fenilalanina
Hipoacusia Congénita	Emisiones Otoacústicas (EOA)	Antes del alta hospitalaria	Potenciales evocados (PEATC)	Audífonos / Implante coclear GES
Cardiopatías Críticas	Oximetría pre y postductal	24 a 48 horas de vida	Ecocardiografía Doppler urgente	Prostaglandina E1 EV si ductus-dependiente

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

PROGRAMA	MOMENTO	CONFIRMACIÓN	TRATAMIENTO
EOA «refiere»	Repetir; PEATC si persiste	Confirma el umbral (sobre 30–35 dB)	Derivar a ORL antes de los 3 meses
Cardiopatía crítica	Oximetría a las 24–48 h	Ecocardiografía urgente	Prostaglandina si depende del ductus

REGLA DE ORO **Se busca en todos** — Aunque el niño se vea sano

PRACTICA **Libro Gordo Pediatría General**, preguntas **3, 89** (págs. 13, 25) · solucionario págs. 26, 36.

Clase 18.21 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · NEONATOLOGÍA & SALA DE PARTOS

18.22 Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC GES N° 23): Maniobras de Ortolani y Barlow, Radiografía a los 3 Meses y Correas de Pavlik

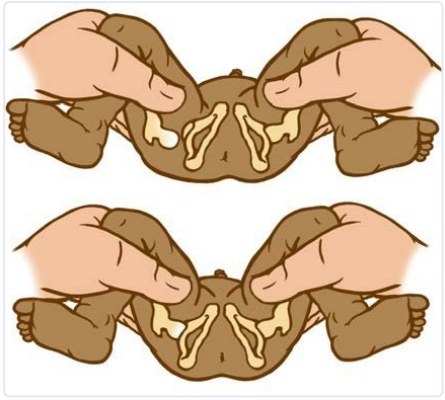
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
7 preguntas reales 2013–2025

2.01.1.092 Displasia de caderas — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Displasia congénita de cadera · Radiografía de pelvis anteroposterior · Prevención de displasia de cadera (diagnóstico precoz)

LO QUE TE PREGUNTAN

- La radiografía de pelvis a los **3 meses** (**80-120 días**) es una garantía GES universal para TODOS los lactantes en Chile.
- **Maniobra de Ortolani**: Reduce la cadera luxada mediante abducción ('clunk' palpable al entrar).
- **Maniobra de Barlow**: Luxa la cadera inestable mediante aducción y empuje posterior.
- En mayores de **3 meses**, el signo más confiable es la limitación de la abducción (< 60°).
- **Radiografía normal**: Cabeza femoral en el cuadrante Ínfero-Interno e índice acetabular **≤ 30°** a los **3 meses**.



MANIOBRA DE ORTOLANI
Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 5430

ALGORITMO · DISPLASIA DE CADERA: EXAMEN E IMAGEN SEGÚN LA EDAD

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



TABLA 18.22 · LÍNEAS E ÍNDICES RADIOLÓGICOS EN LA RADIOGRAFÍA DE PELVIS A LOS 3 MESES

PARÁMETRO RADIOLÓGICO	TRAZADO ANATÓMICO	VALOR NORMAL (3 MESES)	HALLAZGO EN DISPLASIA (DDC)
Línea de Hilgenreiner	Horizontal que une cartílagos trirradiados	Línea basal horizontal	Punto de referencia
Línea de Perkin	Vertical trazada desde el borde acetabular externo	Perpendicular a Hilgenreiner	Delimita cuadrantes
Cuadrantes de Ombredanne	4 cuadrantes formados por cruce de líneas	Núcleo en Cuadrante Ínfero-Interno	Núcleo desplazado a Súpero-Externo
Índice Acetabular	Ángulo entre Hilgenreiner y techo acetabular	≤ 30° (desciende con la edad)	> 30° (acetábulo plano / verticalizado)
Arco de Shenton	Curva entre cuello femoral y rama iliopubiana	Curva continua y suave	Arco roto o discontinuo

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Menor de 3 meses, Ortolani positivo	Derivar y ecografía de caderas	Esperar a la radiografía de los 3 meses
3 meses, sin factores de riesgo	Igual se toma radiografía de pelvis	Omitirla por no tener factores de riesgo
Ángulo acetabular de 30 o menos	Mantener controles habituales	Indicar arnés de todos modos

REGLA DE ORO **Bajo 3 meses: Ortolani y Barlow** — Uno reduce, el otro luxa

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Pediatría General**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 18.22 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

Números que tienes que saber

Cortes, dosis, tiempos y metas de los 28 temas, tal como aparecen en el libro y en las clases. Las cifras van en negrita.

DATO	TIPO
BLOQUE 01 · CRECIMIENTO, DESARROLLO & VACUNAS PNI	
18.1 Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)	pág. 4
Control abreviado — A los **15 a 30 días**	TIEMPO
Varón: testículo de **4 mL** o más — Entre los 9 y **14 años**	DOSIS
5 a 19 años: IMC/Edad — Mismos cortes, otro nombre	CORTE
18.2 Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)	pág. 5
EEDP: 8 y **18 meses** — TEPSI: **3 años**	TIEMPO
Retraso · CD < 70 puntos · Puntaje T < 70 puntos	CORTE
Normal · Coeficiente de Desarrollo (CD) **≥ 85** · Puntaje T **≥ 85**	CORTE
18.3 Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026	pág. 6
PNI: 2, 4 y **6 meses** — Adulto de riesgo: 0, 1 y **6 meses**	TIEMPO
Tresvírica: **12 meses** — Varicela y hepatitis A: **18 meses**	TIEMPO
Anafilaxia: adrenalina IM — **0,01 mg/kg** en el vasto lateral; ESAVI se notifica	DOSIS
18.4 Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación (Vitamina D / Fierro)	pág. 7
Al menos 6 pañales mojados — Desde el día 5; **20 a 30 g**/día de peso	DOSIS
La cena se introduce entre los 8 y **9 meses** de vida.	TIEMPO
Término: **1 mg/kg** desde los 4 — Prematuro: **2 a 3 mg/kg**, desde los **2 meses**	DOSIS
18.26 Genética y Dismorfias: Síndrome de Down (Trisomía 21) y Síndromes Genéticos Frecuentes	pág. 8
Inclusión; esperanza de vida > **55-60 años** — Apoyo a la familia	CORTE
Hipotiroidismo: TSH al nacer, 6 y **12 meses** — Luego anual	TIEMPO
18.28 Pediatría Psicosocial: Maltrato Infantil, Entrevista Clínica, Conductas de Riesgo en el Adolescente y Psiquiatría de Enlace	pág. 9
Intervención breve motivacional — Derivar si es problemático: GES < **20 años**	CORTE
Serie esquelética en menores de **2 años** — TAC o resonancia cerebral	CORTE
BLOQUE 02 · RESPIRATORIO PEDIÁTRICO & URGENCIAS	
18.5 Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado	pág. 10
Saturación bajo **93%** al aire — Meta de **93 a 97%**	META
Retiro gradual — Saturación estable sobre **93%**	CORTE
18.6 Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona	pág. 11
La Dexametasona oral (**0.15 a 0.6 mg/kg**) está formalmente indicada en TODOS los grados de laringitis.	DOSIS
18.7 Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización	pág. 12
Umbrales OMS de taquipnea: <2m: **≥60 rpm**; 2-11m: **≥50 rpm**; **1-4 años**: **≥40 rpm**; **≥5 años**: **≥30 rpm**.	CORTE
Menores de **3 meses**, SatO2 < **93%** o intolerancia oral son criterios de hospitalización inmediata.	CORTE
18.23 Cardiología Pediátrica: Soplos, Insuficiencia Cardíaca, Arritmias, Endocarditis y Electrocardiograma	pág. 14
QTc normal < 0,44 s — **≥ 0,46 s** es prolongado	CORTE
Bloqueo AV completo congénito — FC < 60; lupus materno, anti-Ro/La	CORTE
18.24 Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica, Intoxicaciones y Prevención de Accidentes	pág. 15
Dosis tóxica > **150 mg/kg** — Nivel a las **4 h**: Rumack-Matthew	DOSIS
100 a 120 por minuto — Reexpansión completa; pausas < 10 s	CORTE
BLOQUE 03 · INFECCIONES, EXANTEMAS & DIGESTIVO PEDIÁTRICO	
18.9 Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo	pág. 16
Sube a las **3–6 horas** — **≥ 0,5 ng/mL** bacteriana; **≥ 2 ng/mL**, alto riesgo	DOSIS

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
18.22 Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC GES N° 23): Maniobras de Ortolani y Barlow, Radiografía a los 3 Meses y Correas de Pavlik (cont.)	pág. 31
29 a 90 días — Rochester decide, y es todo o nada	TIEMPO
18.10 Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)	pág. 17
Vitamina A por **2 días** — **200.000 UI** >12 m; **100.000 UI** 6–11 m; **50.000 UI** <6 m	DOSIS
Fiebre alta **3 a 4 días** — El niño se ve bien entre los picos	TIEMPO
Ecocardiograma siempre — Al diagnóstico y a las **6-8 semanas**	TIEMPO
18.11 Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico	pág. 18
Presión y transfusión — Calcioantagonista; glóbulos rojos con Hb < **6–7 g/dL**	DOSIS
Azitromicina, **3 días** — **10 mg/kg**/día; primera línea por resistencia	DOSIS
Moderada — Plan B, sales orales en **4 horas**, en el box	TIEMPO
18.12 Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP) vs Invaginación Intestinal	pág. 19
Confirmación de EHP: Ecografía pilórica (músculo **≥ 3 mm**, longitud **≥ 14 mm**).	CORTE
Dependencia de oxígeno en el prematuro — A los **28 días** y a las **36 semanas** postmenstruales	TIEMPO
18.13 Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis	pág. 20
Relación proteína/creatinina — Normal < 0,2; > **2 mg**/mg es rango nefrótico	DOSIS
Cefadroxilo oral — **3 a 5 días**	TIEMPO
Ambulatorio: cefadroxilo oral — **7 a 10 días**	TIEMPO
18.14 Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico	pág. 21
Inestable o con coagulopatía — Plaquetas < 50.000; infección en el sitio	CORTE
Episodios en 24 Horas · Único en **24 horas** · **≥ 2 episodios** en **24 horas**	CORTE
18.25 Inmunodeficiencias Primarias, Infecciones Recurrentes, Hepatomegalia e Interpretación del Hemograma Pediátrico	pág. 22
RN: Hb **14-20 g/dL** — Nadir fisiológico a los **2-3 meses**: 10-11	DOSIS
Microcítica: ferropenia o talasemia — RDW alto contra normal; Mentzer < 13	CORTE
18.27 Uroginecología Pediátrica: Fimosis, Sinequias Vulvares y Enuresis	pág. 23
Micción involuntaria durante el sueño — **≥ 5 años**, **2 veces** al mes por **3 meses**	CORTE
Completa o sintomática: betametasona **0,05%** — **2 a 4 semanas**; luego emoliente	META
BLOQUE 04 · NEONATOLOGÍA & SALA DE PARTOS	
18.15 Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR	pág. 24
Leve — Hiperalerta, dura menos de **24 horas**	TIEMPO
Leve, moderada, grave — 36–36,4; 32–35,9; bajo **32 °C**	CORTE
18.16 Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal	pág. 25
Hiperoxia, sepsis, transfusiones — Saturación meta **90–95%**	META
37 a 41 semanas — Hasta **41 semanas** y **6 días**	TIEMPO
18.17 Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia	pág. 26
Sube rápido y muy alto — Más de **5 mg/dL** al día	DOSIS
Más de **14 días** en el término — **21 días** en el prematuro	TIEMPO
18.18 Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM	pág. 27
Cafeína — Carga **20 mg/kg**; mantención **5–10 mg/kg**/día	DOSIS
Resuelve en **24 a 72 horas** — Solo con oxígeno de soporte	TIEMPO
18.19 Sepsis Neonatal: Precoz (< 72 h) vs Tardía (> 72 h), Esquema Ampicilina + Aminoglucósido y Cefotaxima	pág. 28
Antes de las **72 horas** — Vertical: estreptococo y E. coli	TIEMPO
Factores de riesgo: Corioamnionitis materna, RPM > **18 horas** y colonización EGB sin profilaxis.	CORTE

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
18.20 Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato	pág. 29
Hematocrito venoso sobre **65%** — O hemoglobina sobre **22 g/dL**	DOSIS
Corregir la causa — Glucosado **10% 2 mL/kg**; gluconato de calcio	DOSIS
18.21 Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo	pág. 30
Tamizaje al mes — Diagnóstico a los **3 meses**	TIEMPO
Prueba de hiperoxia — PaO_2 bajo 150 con FiO_2 **100%**	CORTE
18.22 Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC GES N° 23): Maniobras de Ortolani y Barlow, Radiografía a los 3 Meses y Correas de Pavlik	pág. 31
En mayores de **3 meses**, el signo más confiable es la limitación de la abducción (< 60°).	CORTE
Radiografía normal: Cabeza femoral en el cuadrante Ínfero-Interno e índice acetabular **≤ 30°** a los **3 meses**.	CORTE

Fármacos de primera línea

Esquemas de elección por enfermedad, tomados de las tarjetas de tratamiento de cada clase. Al final de la sección, las garantías GES.

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE	
18.5 **Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado**			pág. 10
Qué pasa si no baja el puntaje · Al terminar la hora	**Alta con salbutamol y control**		
Qué pasa si no baja el puntaje · Al terminar la hora	**Corticoide oral y otra hora**		
Macrólido	**Azitromicina 10 mg/kg/día por 5 días**	De elección en menores de **6 meses**	
18.7 **Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización**			pág. 12
La dosis que se pregunta siempre · Ambulatorio	**Amoxicilina en dosis alta**	Ochenta a noventa por kilo, al día	
La dosis que se pregunta siempre · Hospitalizado	**Ampicilina endovenosa**	Ciento cincuenta a doscientos por kilo	
La dosis que se pregunta siempre · Atípica	**Azitromicina**	No amoxicilina: sin pared celular	
18.23 **Cardiología Pediátrica: Soplos, Insuficiencia Cardíaca, Arritmias, Endocarditis y Electrocardiograma**			pág. 14
Manejo inicial	**Furosemida 1 mg/kg EV**	Repetible; tratar infección, anemia, arritmia	
18.9 **Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo**			pág. 16
Menor de 28 días · Tratamiento empírico	**Ampicilina más cefotaxima**	Cubre listeria, estreptococo y E. coli	
Buen estado general · Antipirético	**Paracetamol es la primera opción**	Quince miligramos por kilo, por dosis	
18.10 **Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)**			pág. 17
Piel de lija y lengua aframbuesada · Por qué importa	**Amoxicilina o penicilina, 10 días**	Completos, no puedes acortarlos	
Diagnóstico, vitamina A y profilaxis · Diagnóstico y tratamiento	**Vitamina A por 2 días**	**200.000 UI** >12 m; **100.000 UI** 6–11 m; **50.000 UI** <6 m	
Diagnóstico y prevención · IgM; tratamiento sintomático	**Vacuna tresvírica a los 12 meses y 1.º básico**		
Tratamiento urgente	**Inmunoglobulina endovenosa**	Dos gramos por kilo, en una sola infusión	
18.11 **Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico**			pág. 18
Síndrome disentérico y Shigella · Cuándo sí das antibiótico	**Azitromicina, 3 días**	**10 mg/kg**/día; primera línea por resistencia	
Síndrome disentérico y Shigella · Cuándo sí das antibiótico	**Casos graves: ceftriaxona**	**50–75 mg/kg**/día, **3–5 días**; o ciprofloxacino	
18.13 **Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis**			pág. 20
Cistitis o pielonefritis · Cistitis o ITU baja	**Cefadroxilo oral**	**3 a 5 días**	
Grados, profilaxis y seguimiento · Profilaxis continua	**Cefadroxilo 10 mg/kg/día; nitrofurantoína nocturna**		
18.16 **Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal**			pág. 25
Suplementos y seguimiento	**Vitamina D y hierro**	**400–800 UI**/día; hierro **2–4 mg/kg**/día desde el mes	
Suplementos y seguimiento	**Vacunas por edad cronológica**	Desarrollo por edad corregida hasta los **2 años**	
18.18 **Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM**			pág. 27
Clínica, radiografía y tratamiento · Prevención y soporte	**Corticoides prenatales a la madre**	Betametasona entre las semanas 24 y 34	

Fármacos de primera línea · continuación

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE	
18.21 Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo (cont.)			pág. 30
Displasia broncopulmonar · Prevención y manejo	**Corticoides prenatales, surfactante precoz, CPAP, cafeína**		
Displasia broncopulmonar · Prevención y manejo	**Diuréticos, broncodilatadores, nirsevimab, vacunas**		
18.19 Sepsis Neonatal: Precoz (< 72 h) vs Tardía (> 72 h), Esquema Ampicilina + Aminoglucósido y Cefotaxima			pág. 28
Esquema para la sepsis tardía	**Vancomicina más amikacina**	O meropenem si hay shock séptico	
18.21 Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo			pág. 30
Confirmación y tratamiento	**Levotiroxina antes de los 15 días**	Para proteger el coeficiente intelectual	

GES de Pediatría y Neonatología

Garantías Explícitas en Salud que aparecen en los temas de esta especialidad: el EUNACOM pregunta la edad, el examen y el plazo que garantizan.

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 19): Infección Respiratoria Aguda (IRA) baja de manejo ambulatorio en menores de 5 años.**

Tema **18.5** · Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado
`2.01.1.020` · `2.01.1.028` · `2.01.2.005`
pág. **10**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 19): Infección Respiratoria Aguda (IRA) baja y alta de manejo ambulatorio en menores de 5 años.**

Tema **18.6** · Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona
`2.01.1.025` · `2.01.1.022` · `2.01.2.018`
pág. **11**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 19): Infección Respiratoria Aguda baja de manejo ambulatorio en menores de 5 años.**

Tema **18.7** · Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización
`2.01.1.024` · `2.01.4.001`
pág. **12**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 1): Retinopatía del prematuro · (GES N° 2): Displasia broncopulmonar del prematuro.**

Tema **18.16** · Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal
`2.01.1.128` · `2.01.1.123` · `6.02.1.022`
pág. **25**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 1 y N° 2): Atención del prematuro extremo · Síndrome de Dificultad Respiratoria en el recién nacido.**

Tema **18.18** · Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM
`2.01.1.126` · `2.01.1.125` · `2.01.1.123`
pág. **27**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 34): Hipotiroidismo congénito · (GES N° 45): Fenilcetonuria (PKU).**

Tema **18.21** · Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo
`2.01.1.075` · `6.03.1.014` · `2.01.1.050`
pág. **30**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 23): Displasia del desarrollo de la cadera en menores de 1 año · Radiografía de pelvis universal a los 3 meses en todo lactante de la red de salud.**

Tema **18.22** · Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC GES N° 23): Maniobras de Ortolani y Barlow, Radiografía a los 3 Meses y Correas de Pavlik
`2.01.1.092` · `4.02.1.002` · `2.01.4.007`
pág. **31**

Sin garantía GES específica (21 temas): 18.1 · 18.2 · 18.3 · 18.4 · 18.26 · 18.28 · 18.8 · 18.23 · 18.24 · 18.9 · 18.10 · 18.11 · 18.12 · 18.13 · 18.14 · 18.25 · 18.27 · 18.15 · 18.17 · 18.19 · 18.20. Revisa igual la norma MINSAL que cita cada página.

Plan de repaso de 7 días

Los temas van de mayor a menor prioridad (★ según preguntas reales EUNACOM 2013–2025). Cada día: lee la página del tema, recorre su algoritmo y haz sus preguntas del Libro Gordo; corrige con el solucionario.

DÍA 1

5 temas · ★★★

- ★★★ **18.10** Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki) 17
- ★★★ **18.1** Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T) 4
- ★★★ **18.3** Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026 6
- ★★★ **18.2** Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI) 5
- ★★★ **18.13** Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis 20

Practica: Libro Gordo Pediatría General, preguntas 8–11, 20, 47–48, 67, 73.

DÍA 2

5 temas · ★★★

- ★★★ **18.11** Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico 18
- ★★★ **18.4** Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación (Vitamina D / Fierro) 7
- ★★★ **18.17** Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia 26
- ★★★ **18.15** Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR 24
- ★★★ **18.21** Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo 30

Practica: Libro Gordo Pediatría General, preguntas 3, 49–50, 68, 70, 76, 80, 89.

DÍA 3

5 temas · ★★

- ★★☆ **18.7** Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización 12
- ★★☆ **18.5** Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado 10
- ★★☆ **18.12** Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP) vs Invaginación Intestinal 19
- ★★☆ **18.22** Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC GES N° 23): Maniobras de Ortolani y Barlow, Radiografía a los 3 Meses y Correas de Pavlik 31
- ★★☆ **18.8** Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía 13

Practica: Libro Gordo Pediatría General, preguntas 12–18, 27–31, 51, 53, 57, 74, 90.

DÍA 4

5 temas · ★★

- ★★☆ **18.23** Cardiología Pediátrica: Soplos, Insuficiencia Cardíaca, Arritmias, Endocarditis y Electrocardiograma 14
- ★★☆ **18.24** Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica, Intoxicaciones y Prevención de Accidentes 15
- ★★☆ **18.16** Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal 25
- ★★☆ **18.14** Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico 21
- ★☆☆ **18.27** Uroginecología Pediátrica: Fimosis, Sinequias Vulvares y Enuresis 23

Practica: Libro Gordo Pediatría General, preguntas 40, 45–46, 52, 65, 69, 83, 86.

DÍA 5

4 temas · ★

- ★☆☆ **18.18** Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM 27
- ★☆☆ **18.28** Pediatría Psicosocial: Maltrato Infantil, Entrevista Clínica, Conductas de Riesgo en el Adolescente y Psiquiatría de Enlace 9
- ★☆☆ **18.6** Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona 11
- ★☆☆ **18.25** Inmunodeficiencias Primarias, Infecciones Recurrentes, Hepatomegalia e Interpretación del Hemograma Pediátrico 22

Practica: Libro Gordo Pediatría General, preguntas 26, 54, 59, 63, 85.

DÍA 6

4 temas · ★

- ★☆☆ **18.20** Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato 29
- ★☆☆ **18.26** Genética y Dismorfias: Síndrome de Down (Trisomía 21) y Síndromes Genéticos Frecuentes 8
- ★☆☆ **18.19** Sepsis Neonatal: Precoz (< 72 h) vs Tardía (> 72 h), Esquema Ampicilina + Aminoglucósido y Cefotaxima 28
- ★☆☆ **18.9** Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo 16

Practica: Libro Gordo Pediatría General, preguntas 5–6, 32–36, 71–72, 84, 87–88.

Plan de repaso de 7 días · continuación

DÍA 7

- Relee «**Números que tienes que saber**» y «**Fármacos de primera línea**» pág. 32
- Repasa solo las **Trampas EUNACOM** y la **Regla de oro** de los temas ★★★: 18.1 · 18.2 · 18.3 · 18.4 · 18.10 · 18.11 · 18.13 · 18.15 · 18.17 · 18.21
- Simulacro: las **90 preguntas** del Libro Gordo Pediatría General en 120 minutos; vuelve a la página de cada tema que falles.

Índice por prioridad ★

El número a la izquierda es la cantidad de preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) en los códigos Perfil V3 del tema.

★★★ Prioridad alta · 10 temas

38 18.10. Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki) 17

21 18.1. Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T) 4

20 18.3. Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026 6

19 18.2. Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI) 5

16 18.13. Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis 20

15 18.11. Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico 18

12 18.4. Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación (Vitamina D / Fierro) 7

12 18.17. Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia 26

11 18.15. Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR 24

11 18.21. Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo GES 30

★★ Prioridad media · 9 temas

10 18.7. Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización GES 12

8 18.5. Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado GES 10

8 18.12. Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP) vs Invaginación Intestinal 19

7 18.22. Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC GES N° 23): Maniobras de Ortolani y Barlow, Radiografía a los 3 Meses y Correas de Pavlik GES 31

6 18.8. Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía 13

6 18.23. Cardiología Pediátrica: Soplos, Insuficiencia Cardíaca, Arritmias, Endocarditis y Electrocardiograma 14

6 18.24. Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica, Intoxicaciones y Prevención de Accidentes 15

6 18.16. Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal GES 25

5 18.14. Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico 21

★ Prioridad baja · 9 temas

4 18.27. Uroginecología Pediátrica: Fimosis, Sinequias Vulvares y Enuresis 23

3 18.18. Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM GES 27

2 18.28. Pediatría Psicosocial: Maltrato Infantil, Entrevista Clínica, Conductas de Riesgo en el Adolescente y Psiquiatría de Enlace 9

2 18.6. Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona GES 11

2 18.25. Inmunodeficiencias Primarias, Infecciones Recurrentes, Hepatomegalia e Interpretación del Hemograma Pediátrico 22

2 18.20. Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato 29

1 18.26. Genética y Dismorfias: Síndrome de Down (Trisomía 21) y Síndromes Genéticos Frecuentes 8

1 18.19. Sepsis Neonatal: Precoz (< 72 h) vs Tardía (> 72 h), Esquema Ampicilina + Aminoglucósido y Cefotaxima 28

0 18.9. Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo 16